AEE

ACADEMIA EXAMEN EUNACOM

1ª EDICIÓN · 2026

SERIE AEE · PERFIL V3

REPASO FINAL

ENFERMEDADES RESPIRATORIAS

Neumología

25 temas · 1 página cada uno · **7** días de plan de repaso

Índice

Cómo usarlo. Un tema por página: lee «Lo que te preguntan», recorre el algoritmo y termina en las trampas y la regla de oro. Después haz las preguntas del Libro Gordo que indica el pie.

★★★ alta · ★★☆ media · ★☆☆ baja — según cuántas preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) hay en los códigos del tema.
Niveles Perfil V3: **Dx** diagnóstico · **Tx** tratamiento · **Seg** seguimiento.

01 Vía Aérea Obstructiva y Función Pulmonar

★★☆ 1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar GES 3
★☆☆ 1.2. Crisis Asmática en el Adulto GES 4
★★★ 1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES GES 5
★★★ 1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable GES 6
★★★ 1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) GES 7

02 Infecciones Respiratorias Bajas y Supuraciones

★★★ 2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 GES 8
★☆☆ 2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES GES 9
★☆☆ 2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa 10
★☆☆ 2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares 11
★★★ 2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento GES 12

03 Patología Pleural y Urgencias Torácicas

★★☆ 3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light 13
★★☆ 3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural 14
★★☆ 3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario 15
★☆☆ 3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático GES 16
★★☆ 3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa GES 17

04 Oncología Pulmonar, Intersticio y Vascular

★★☆ 4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner GES 18
★★★ 4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial GES 19
★★★ 4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática 20
★★★ 4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación 21
★★★ 4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias 22

05 Cuidados Críticos, Ventilación y Medicina del Sueño

★★☆ 5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) 23
★☆☆ 5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín 24
★★☆ 5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) 25
★★☆ 5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo 26
★☆☆ 5.5. Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental 27

Números que tienes que saber 28
Fármacos de primera línea 31
GES de la especialidad 32
Plan de repaso de 7 días 34
Índice por prioridad ★ 35

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar

Alta · Pregunta fija sobre interpretación de curvas y reversibilidad

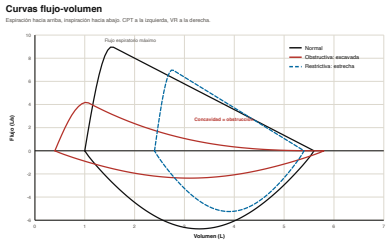
★★☆ **PRIORIDAD MEDIA**
4 preguntas reales 2013–2025

1.05.4.005 Espirometría — Interpreta y emplea

También: Prueba de provocación bronquial con fármacos

LO QUE TE PREGUNTAN

- El patrón obstructivo se define estrictamente por VEF1/CVF < 0.70 post-broncodilatador.
- **Test BD positivo**: aumento del VEF1 o CVF **≥ 12%** Y **≥ 200 mL** respecto al basal.
- **La severidad obstructiva se clasifica según el VEF1 post-BD**: **≥80%** leve, **50-79%** moderada, **30-49%** grave, <**30%** muy grave.
- **Trampa**: la espirometría jamás confirma restricción; solo la sugiere cuando la CVF es < **80%** con VEF1/CVF normal.
- La confirmación categórica de restricción pulmonar exige pletismografía demostrando CPT < **80%**.



LAS TRES CURVAS
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · LECTURA SISTEMÁTICA DE LA ESPIROMETRÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

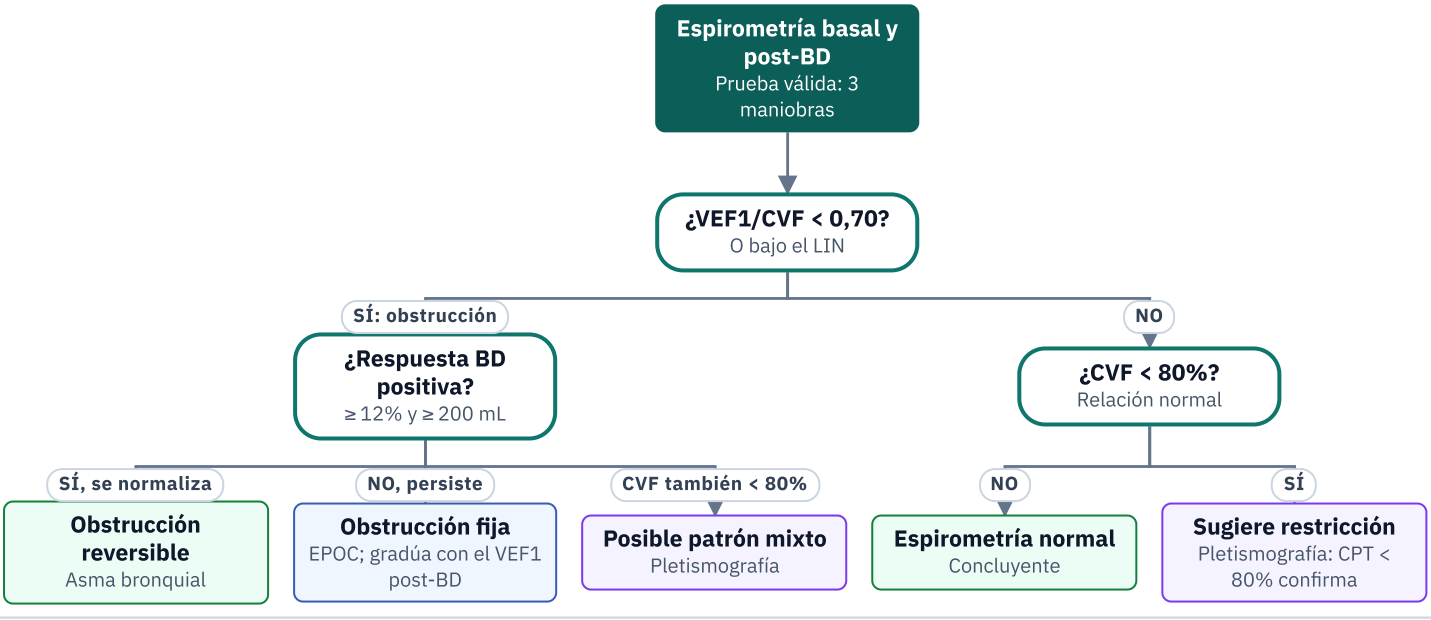


TABLA 1.1 · PATRONES ESPIROMÉTRICOS FUNDAMENTALES Y PRUEBAS CONFIRMATORIAS

PATRÓN ESPIROMÉTRICO	VEF1/CVF	CVF (% PREDICHO)	VEF1 (% PREDICHO)	EXAMEN DE CONFIRMACIÓN
Normal	≥ 0.70	≥ 80%	≥ 80%	Espirometría normal concluyente
Obstructivo Reversible	< 0.70	Normal o baja	Variable (mejora >12% y 200 mL)	Test Broncodilatador (Asma)
Obstructivo Fijo	< 0.70 post-BD	Normal o baja	Reducido post-BD	Espirometría post-BD (EPOC)
Sugerente de Restricción	≥ 0.70	< 80%	Proporcionalmente bajo	Pletismografía (CPT < 80%)
Mixto (Obstr + Restr)	< 0.70	< 80%	Muy disminuido	Pletismografía (CPT baja + VEF1/CVF bajo)

REGLA DE ORO **VEF1/CVF < 0,70 define** — El VEF1 post-BD gradúa

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **3–7** (págs. 9–10) · solucionario págs. 24–25.

Clase 1.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

1.2 Crisis Asmática en el Adulto

★☆☆
PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.05.2.004 **Crisis de asma bronquial** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Flujo espiratorio máximo (PEF: Peak Expiratory Flow) · Gases en sangre arterial · Nebulizaciones

LO QUE TE PREGUNTAN

- Un PaCO2 "normal" (**40 mmHg**) en un paciente con crisis asmática y taquipnea es signo de alarma extrema de fatiga muscular inminente.
- El tórax silente (ausencia de sibilancias con esfuerzo respiratorio) refleja una caída crítica del flujo aéreo y riesgo inminente de paro respiratorio.
- El corticoide sistémico oral (Prednisona **40-50 mg**) tiene la misma biodisponibilidad y rapidez que la vía EV; debe administrarse en la primera hora.
- En crisis severa refractaria a SABA + Ipratropio en la primera hora, el fármaco de rescate de elección es Sulfato de Magnesio **2 g** EV en **20 minutos**.
- No se realiza pauta descendente de corticoides sistémicos si el ciclo dura entre 5 y **7 días**.
- El inhalador presurizado de dosis medida (MDI) con aerocámara es tan eficaz como la nebulización continua y produce menor taquicardia.

ALGORITMO · CRISIS ASMÁTICA EN EL SERVICIO DE URGENCIA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

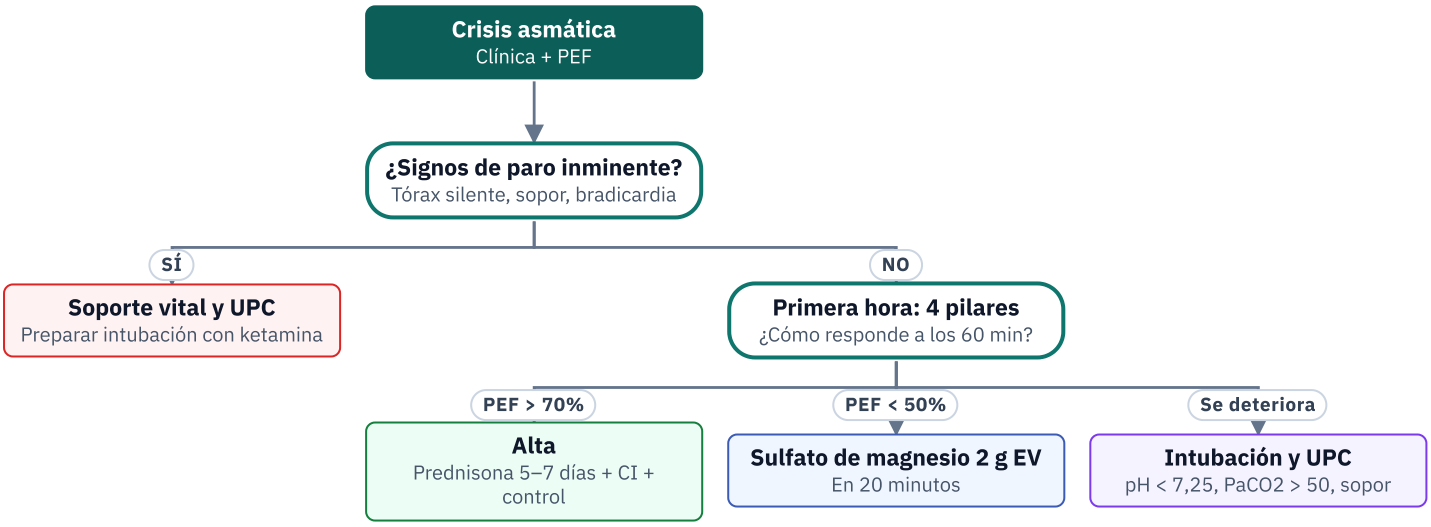


TABLA 1.2 · ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA Y GASOMÉTRICA DE LA CRISIS ASMÁTICA

SEVERIDAD	DISNEA Y HABLA	FC Y FR	PEF (% TEÓRICO)	GASES ARTERIALES (GSA)
Leve / Moderada	Párrafos o frases completas	FC < 100-110, FR < 25	≥ 50% - 70%	Alcalosis respiratoria (PaCO2 < 35, hipocapnia)
Grave	Frases cortas o palabras	FC > 120, FR > 30	< 50%	Hipoxemia moderada, PaCO2 normalizante (38-42)
Paro Inminente	Incapaz de hablar, sopor	Bradicardia, agotamiento	< 30% o no medible	Acidosis respiratoria grave (PaCO2 > 45 mmHg)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Taquipneico con PaCO2 de 40	Agotamiento inminente: preparar soporte	Leerlo como gases normales
Deja de sibilar sin mejorar	Tórax silente: riesgo de paro	Pensar que mejoró
Alta de urgencia	Prednisona 5–7 días, sin descenso	Solo salbutamol, o ciclo largo con descenso

REGLA DE ORO **Palabras, FC > 120, FR > 30, PEF < 50%** — Crisis grave

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **8–10** (pág. 10) · solucionario pág. 25.

Clase 1.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES

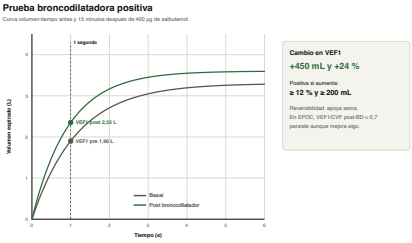
★★★ PRIORIDAD ALTA
13 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.003 Asma bronquial leve y moderada — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Asma bronquial grave · Espirometría · Asma bronquial · Tos crónica · Inhalación de aerosoles presurizados

LO QUE TE PREGUNTAN

- El uso de Salbutamol (SABA) como monoterapia está contraindicado por aumentar el riesgo de crisis mortales.
- El corticoide inhalado (CI) es la piedra angular del tratamiento del asma crónica.
- **En cada control se evalúan 4 criterios en el último mes**: síntomas diurnos, nocturnos, uso de rescate y limitación funcional.
- Antes de subir un escalón terapéutico (Step-up), siempre revisar la técnica inhalatoria y la adherencia al fármaco.
- El tratamiento con Budesonida/Formoterol como rescate y mantenimiento (MART) reduce significativamente las exacerbaciones.



ANTES Y DESPUÉS
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · ASMA CRÓNICA: DIAGNÓSTICO, CONTROL Y ESCALONES

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

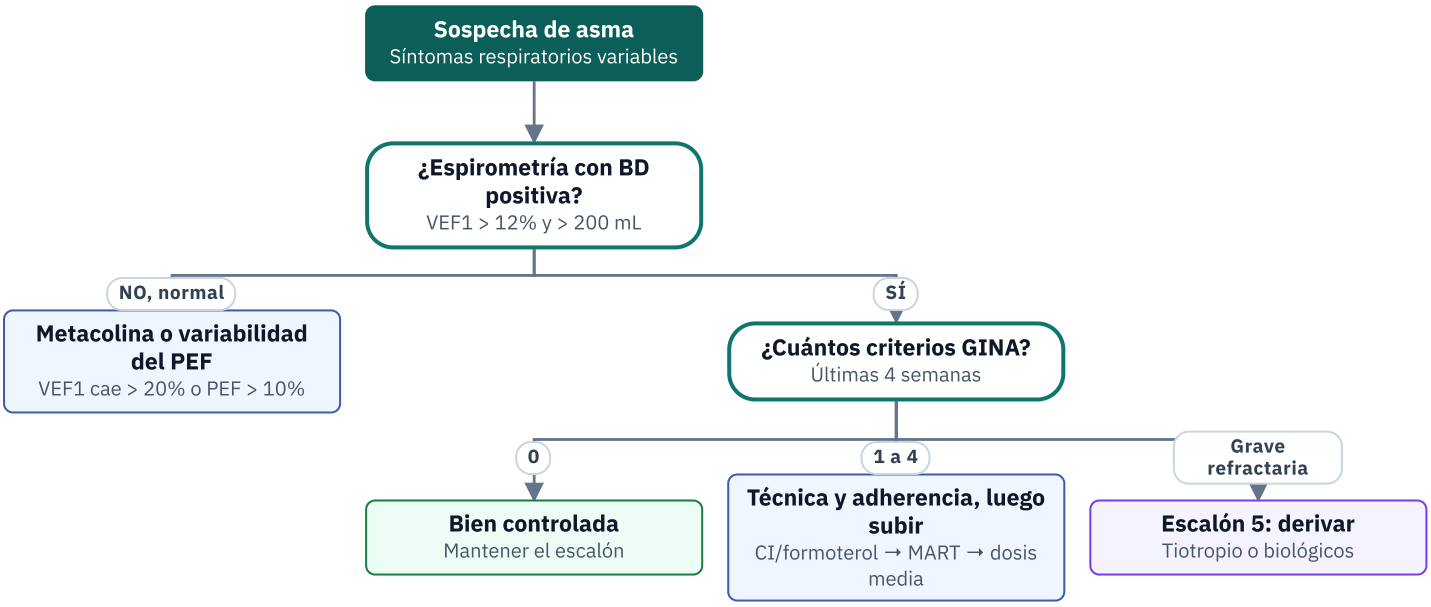


TABLA 1.3 · ESCALONES TERAPÉUTICOS GINA PARA MAYORES DE 12 AÑOS

ESCALÓN GINA	TRATAMIENTO PREFERIDO (VÍA 1)	ALTERNATIVA (VÍA 2)	PERFIL DE PACIENTE
Escalón 1 y 2	Budesonida/Formoterol dosis baja SOS	CI diario a dosis baja + SABA SOS	Síntomas < 4-5 días a la semana
Escalón 3	CI dosis baja + LABA diario + rescate MART	CI dosis baja + LABA + SABA SOS	Síntomas la mayoría de los días o despierta ≥ 1/sem
Escalón 4	CI dosis media + LABA diario + rescate MART	CI dosis media + LABA + SABA SOS	Asma no controlada con escalón 3
Escalón 5	CI dosis alta + LABA + agregar LAMA / derivar	Evaluar fenotipo biológico (anti-IgE)	Asma grave refractaria especializada

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Síntomas típicos, espirometría normal	Test de metacolina	Descartar el asma
Asmático solo con salbutamol	Agregar corticoide inhalado	Mantener SABA en monoterapia
Parcial o no controlada	Revisar técnica y adherencia	Subir el escalón de inmediato

REGLA DE ORO **Espirometría normal no descarta** — Metacolina: VEF1 cae > 20%

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **11–14** (págs. 10–11) · solucionario págs. 25–26.

Clase 1.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable

★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.017 **Enfermedad pulmonar obstructiva crónica leve y moderada** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Enfermedad pulmonar obstructiva crónica avanzada · Espirometría · Tabaquismo: prevención, cesación y efectos nocivos para la salud · Bronquitis crónica · Corazón pulmonar crónico

LO QUE TE PREGUNTAN

- Las únicas medidas que prolongan la sobrevida en EPOC son el cese del tabaco y el oxígeno domiciliario crónico (**≥15 h/día**).
- **Criterio de oxígeno domiciliario**: PaO2 **≤ 55 mmHg** o PaO2 **56-59 mmHg** si hay cor pulmonale o poliglobulia (Hto > **55%**).
- El esquema GOLD 2024 unificó los grupos C y D en el "Grupo E" (exacerbadores frecuentes), indicando LAMA + LABA inicial.
- Los corticoides inhalados (CI) en monoterapia están contraindicados en EPOC; aumentan el riesgo de neumonía bacteriana.
- El corticoide inhalado solo se indica como terapia triple (LABA+LAMA+CI) si los eosinófilos en sangre son **≥ 300/uL**.



HIPERINSUFLACIÓN
The Chest X-Ray: A Survival Guide, Fig. 22.2

ALGORITMO · EPOC ESTABLE: DEL DIAGNÓSTICO AL TRATAMIENTO

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

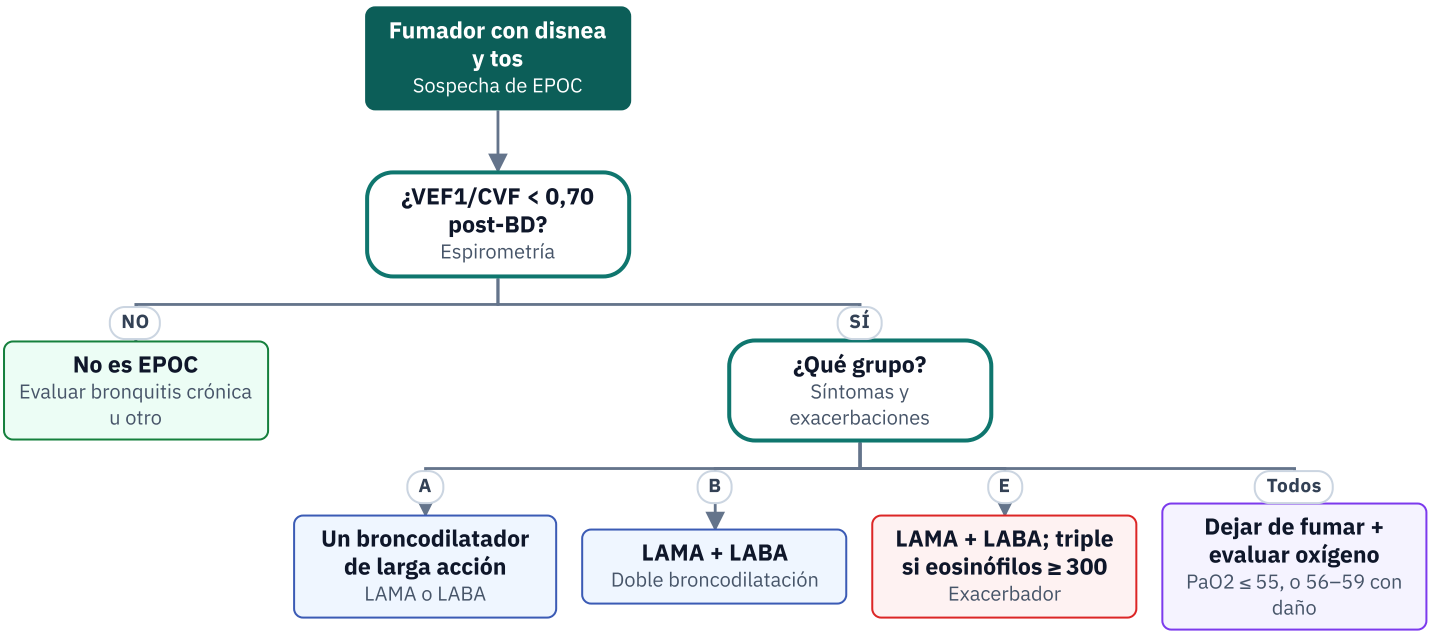


TABLA 1.4 · CLASIFICACIÓN GOLD A-B-E Y TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO INICIAL

GRUPO GOLD	HISTORIAL DE EXACERBACIONES	SÍNTOMAS (MMRC / CAT)	TRATAMIENTO INICIAL RECOMENDADO
Grupo A	0 o 1 moderada (sin hospitalizar)	mMRC 0-1 / CAT < 10	Broncodilatador de larga acción (LAMA o LABA)
Grupo B	0 o 1 moderada (sin hospitalizar)	mMRC ≥ 2 / CAT ≥ 10	Doble broncodilatación: LAMA + LABA
Grupo E	≥ 2 moderadas o ≥ 1 con hospitalización	Cualquier nivel de síntomas	LAMA + LABA (considerar CI si Eosinófilos ≥ 300/uL)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Fumador con tos, espirometría normal	No es EPOC	Diagnosticar EPOC por el tabaco
Exacerbador, eosinófilos ≥ 300/µL	Triple: LAMA + LABA + CI	CI solo
¿Qué aumenta la sobrevida?	Dejar de fumar y oxígeno ≥ 15 h	Broncodilatadores o corticoides

REGLA DE ORO **VEF1/CVF < 0,70 post-BD** — Sin obstrucción no hay EPOC

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **15–16** (pág. 11) · solucionario pág. 26.

Clase 1.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR

1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)

★★★ PRIORIDAD ALTA
8 preguntas reales 2013–2025

1.05.2.006 Enfermedad bronquial obstructiva crónica descompensada — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Ventilación mecánica no invasiva · Gases en sangre arterial · Corazón pulmonar crónico

LO QUE TE PREGUNTAN

- Los criterios de Anthonisen guían la indicación de antibióticos: se indican en Tipo 1 (3 criterios) o Tipo 2 si uno de los criterios es esputo purulento.
- El patógeno bacteriano más frecuentemente aislado en las exacerbaciones de EPOC es Haemophilus influenzae.
- El esquema corticoideo de elección avalado por el estudio REDUCE es Prednisona **40 mg**/día durante exactamente **5 días** (sin pauta descendente).
- La meta de saturación en EPOC descompensado es estrictamente **88–92%**; la hiperoxia suprime la vasoconstricción hipóxica y desencadena coma hipercápnico.
- La Ventilación Mecánica No Invasiva (BiPAP) es la indicación de elección de primera línea ante acidosis respiratoria hipercápnica (pH < 7.35 y PaCO2 > **45 mmHg**).
- La VMNI reduce la necesidad de intubación orotraqueal en más de **50%** y disminuye significativamente la mortalidad intrahospitalaria.

ALGORITMO · EXACERBACIÓN DE EPOC: GASES Y ANTHONISEN

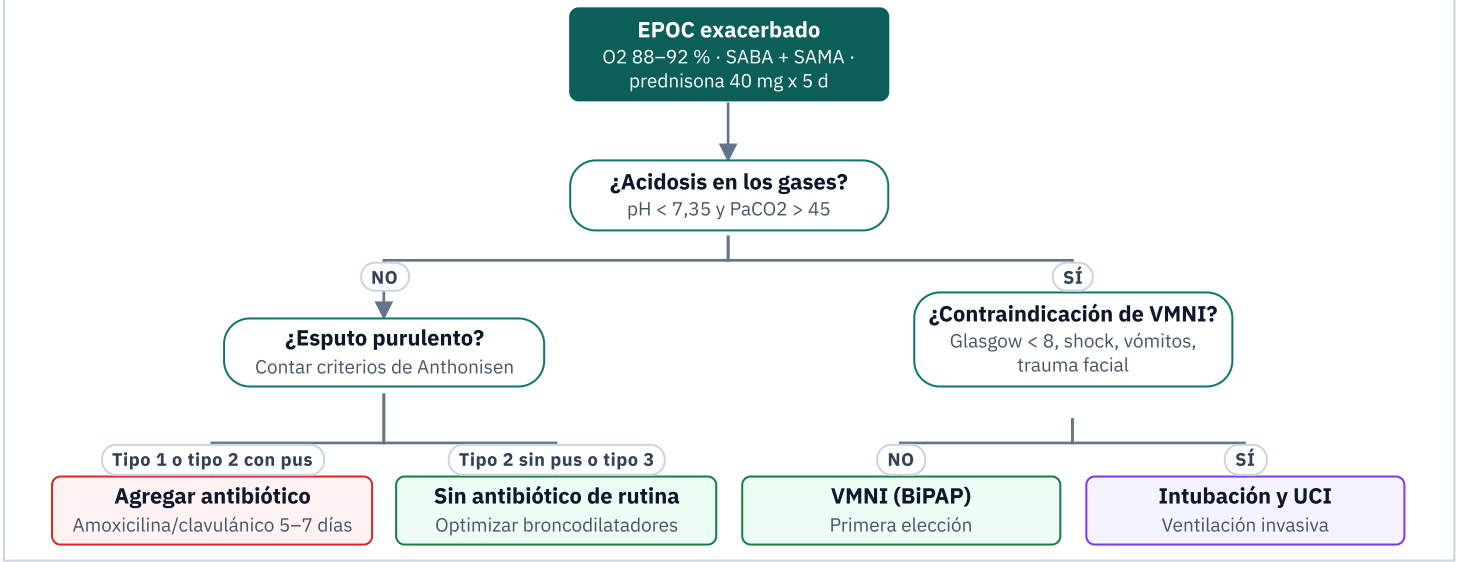


TABLA 1.5 · CRITERIOS DE ANTHONISEN E INDICACIÓN ANTIMICROBIANA EN EXACERBACIÓN DE EPOC

TIPO DE ANTHONISEN	CRITERIOS PRESENTES	¿REQUIERE ANTIBIÓTICOS?	TRATAMIENTO MÉDICO OBLIGATORIO
Tipo 1 (Grave)	Aumento disnea + aumento esputo + purulencia	SÍ (100% de los casos)	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB
Tipo 2 (Moderada)	2 criterios (con esputo purulento)	SÍ (por la purulencia)	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d + ATB
Tipo 2 (Moderada)	2 criterios (disnea + volumen SIN purulencia)	NO indicado de rutina	SABA + SAMA + Prednisona 40 mg x 5d
Tipo 3 (Leve)	1 criterio cardinal + tos/fiebre/faringitis	NO indicado	Optimizar SABA + SAMA (reevaluar)

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Más disnea + más esputo, sin purulencia	Sin antibiótico de rutina	Dar antibiótico por tener 2 criterios
EPOC desaturado en urgencia	O2 por cánula o Venturi, meta 88–92 %	Mascarilla con reservorio a 15 L/min
Somnoliento tras subir el O2	Bajar FiO2 + VMNI	Sedar o subir más el oxígeno

REGLA DE ORO **Tipo 1, o tipo 2 con purulencia** — Amoxicilina/clavulánico 5–7 días

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **17–18** (pág. 11) · solucionario pág. 26.

Clase 1.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65

★★★ PRIORIDAD ALTA
14 preguntas reales 2013–2025

Máxima · Tema central de medicina interna en todos los exámenes

1.05.1.027 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias) — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Radiografía de tórax · Bronquitis aguda · Examen microbiológico de expectoración

LO QUE TE PREGUNTAN

- La confirmación de NAC exige siempre una Radiografía de tórax demostrando condensación o infiltrados nuevos.
- El germen más común de NAC en todas las edades y comorbilidades es Streptococcus pneumoniae.
- **CURB-65**: Confusión (+1), Urea > **42 mg/dL** o BUN > 19 (+1), FR **≥ 30** (+1), PAS < 90 o PAD **≤ 60** (+1), Edad **≥ 65** (+1).
- **CURB-65 de 0 a 1 punto**: manejo ambulatorio. 2 puntos: hospitalización en sala. **≥ 3 puntos**: evaluar UCI/UTI.
- Si el único punto en CURB-65 es la edad (**≥ 65 años**), el paciente puede ser manejado ambulatoriamente si no hay hipoxemia ni riesgo social.
- **Criterios mayores para UCI directa según ATS/IDSA**: necesidad de ventilación mecánica invasiva o shock séptico refractario con vasopresores.
- **La NAC en mayores de 65 años es patología GES**: garantiza diagnóstico y tratamiento antibiótico en menos de **24 horas**.



CONSOLIDACIÓN LOBAR
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 13

ALGORITMO · NAC: CONFIRMAR Y DECIDIR EL LUGAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

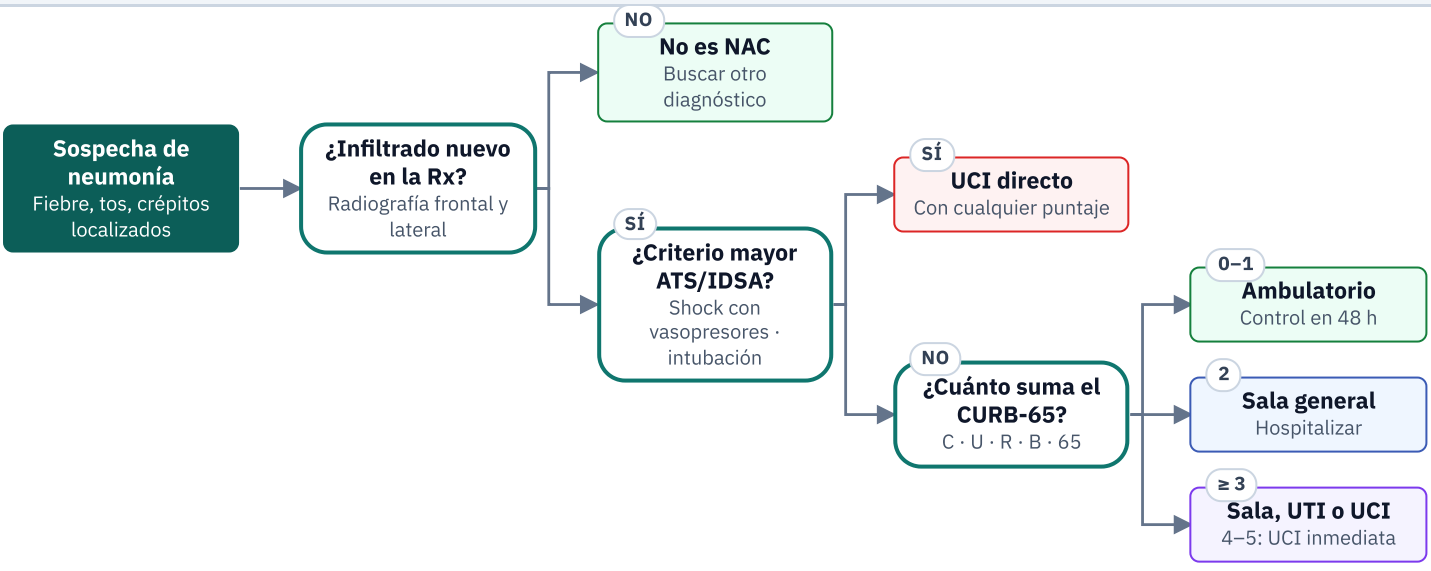


TABLA 2.1 · SCORE CURB-65: ESTRATIFICACIÓN DE MORTALIDAD Y SITIO DE MANEJO

PUNTAJE CURB-65	RIESGO CLÍNICO	MORTALIDAD A 30 DÍAS	SITIO DE ATENCIÓN RECOMENDADO
0 puntos	Bajo	0.7%	Ambulatorio en domicilio
1 punto	Bajo	2.1%	Ambulatorio (si el único punto es edad ≥ 65 a)
2 puntos	Moderado	9.2%	Hospitalización en sala general (o corta estancia supervisada)
3 puntos	Grave	14.5%	Hospitalización en sala o UTI (evaluar criterios ATS/IDSA)
4 o 5 puntos	Muy Grave	40.0%	Hospitalización inmediata en UCI

REGLA DE ORO **Sin radiografía no hay NAC** — Infiltrado nuevo

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **19–24** (pág. 12) · solucionario págs. 26–27.

Clase 2.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES

Máxima · Esquemas empíricos MINSAL y ajustes según lugar de internación

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.05.1.028 Neumonías adquiridas en la comunidad (tipos 1, 2 y 3 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias) — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

LO QUE TE PREGUNTAN

- **NAC ambulatoria en joven sano sin comorbilidades**: Amoxicilina **1 g** c/**8h** VO por **5 a 7 días**.
- **NAC ambulatoria en mayor de 65 años o con comorbilidades (GES)**: Amoxicilina/Ácido Clavulánico 875/**125 mg** c/**12h**.
- **NAC hospitalizada en sala general**: Ceftriaxona **1-2 g** al día EV (asociar Azitromicina si sospecha de atípico).
- **NAC en UCI**: Betalactámico EV (Ceftriaxona **2 g**) + Quinolona respiratoria (Levofloxacino) o Macrólido EV.
- El cambio a vía oral se realiza con **48 horas** afebril, estabilidad hemodinámica y buena tolerancia oral.

ALGORITMO · NAC: ANTIBIÓTICO SEGÚN EL LUGAR

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

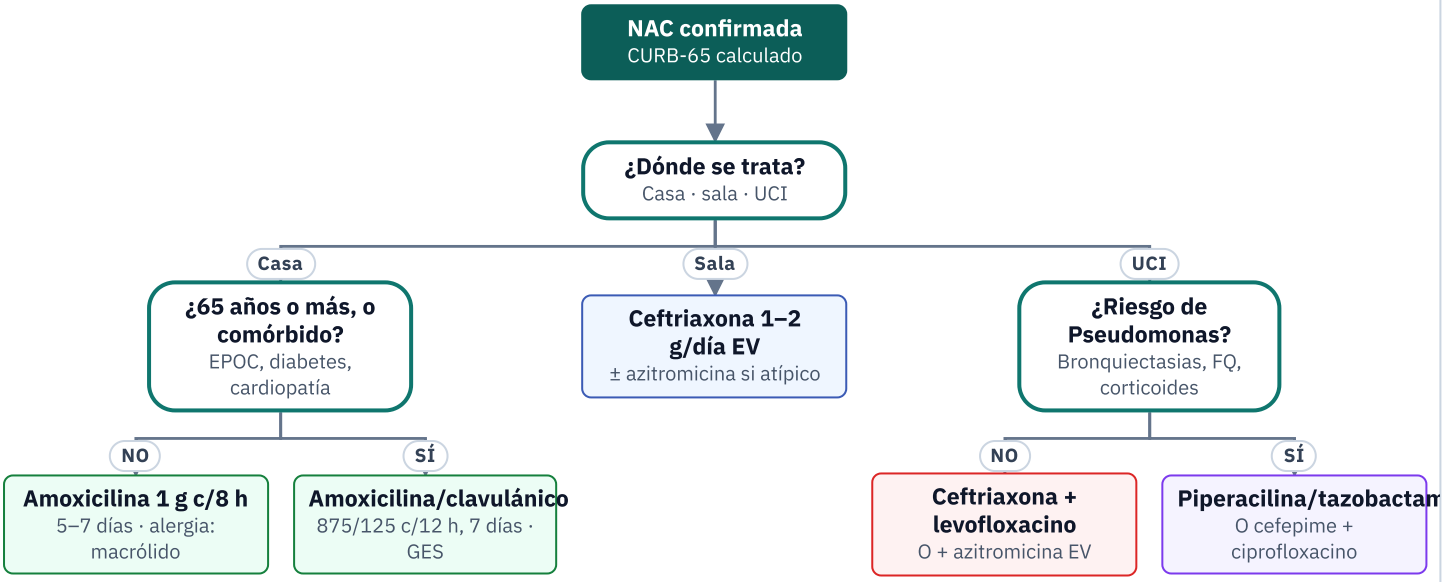


TABLA 2.2 · TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO EMPÍRICO DE LA NAC SEGÚN GUÍAS CHILENAS MINSAL

ESCENARIO CLÍNICO	ANTIBIÓTICO DE 1.ª LÍNEA	VÍA Y DOSIS	ALTERNATIVA ALERGIA A PENICILINA
Ambulatorio < 65 a sano	Amoxicilina	1 g c/8h VO por 5-7 días	Azitromicina 500 mg/d (o Claritromicina 500 mg c/12h)
Ambulatorio ≥ 65 a / comórbido (GES)	Amoxicilina / Ácido Clavulánico	875/125 mg c/12h VO por 7 días	Cefuroximo 500 mg c/12h o Levofloxacino 750 mg/d
Hospitalizado Sala General	Ceftriaxona (± Azitromicina)	1-2 g/día EV (Azitro 500 mg/d VO)	Levofloxacino 750 mg/d EV o Moxifloxacino 400 mg/d
Hospitalizado UCI (Grave)	Ceftriaxona + Levofloxacino (o Azitro)	Ceftriaxona 2 g EV + Levo 750 mg EV	Levofloxacino + Vancomicina (si riesgo MRSA)

REGLA DE ORO **< 65 sano: amoxicilina** — 1 g c/8 h · alergia: macrólido

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **25–26** (págs. 12–13) · solucionario pág. 27.

Clase 2.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
1 pregunta real 2013–2025

1.05.1.030 Neumonías nosocomiales — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Neumonías adquiridas en la comunidad (tipo 4 de la Sociedad Chilena de Enf. Respiratorias) · Supuración pulmonar · Gram

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Mycoplasma y Chlamydia carecen de pared de peptidoglicano**: son **100%** resistentes a penicilinas y cefalosporinas.
- La disociación clínico-radiológica (auscultación pobre con radiografía con extensos infiltrados) sugiere neumonía atípica.
- La neumonía aspirativa ocurre en pacientes con trastorno de conciencia o deglución y afecta segmentos declives derechos.
- **Fármaco de elección en sospecha de aspiración y anaerobios**: Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Ácido Clavulánico.
- La neumonía intrahospitalaria (NIH) se define por aparición tras **48 horas** del ingreso; exige cobertura antipseudomónica.



MYCOPLASMA
Manual CTO Infecciosas 14.ª ed., p. 56

ALGORITMO · NEUMONÍA: ¿SIRVE EL ESQUEMA HABITUAL?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

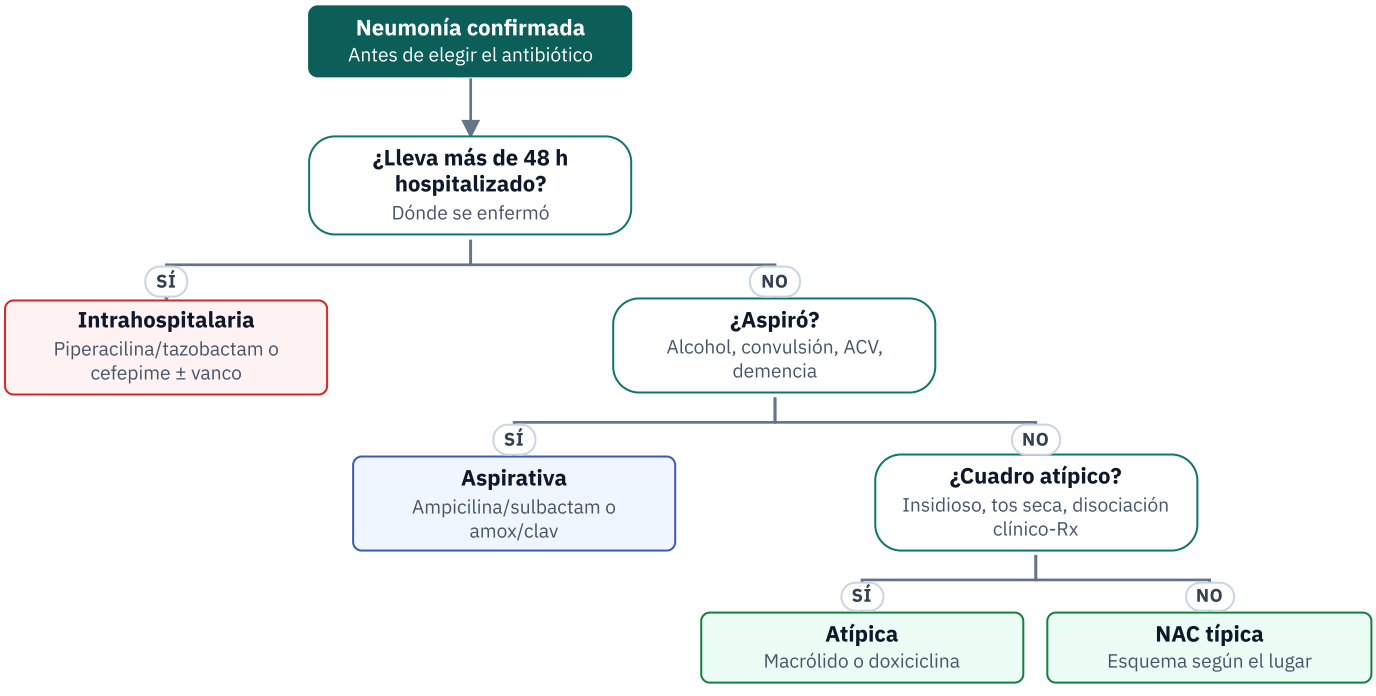


TABLA 2.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: NAC ATÍPICA VS ASPIRATIVA VS INTRAHOSPITALARIA (NIH)

TIPO DE NEUMONÍA	POBLACIÓN TÍPICA	MICROBIOLOGÍA CARDINAL	ESQUEMA TERAPÉUTICO DE ELECCIÓN
NAC Atípica	Jóvenes, cuarteles, estudiantes	Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophila	Azitromicina 500 mg/d o Doxiciclina 100 mg c/12h
Aspirativa	Alcohólicos, secuela ACV, demencia	Flora mixta anaerobia + estreptococos orales	Ampicilina/Sulbactam o Amoxicilina/Clavulánico
Intrahospitalaria (NIH)	Hospitalizado > 48 horas	Pseudomonas, Enterobacterias BLEE, SAMR	Piperacilina/Tazo o Cefepime (± Vancomicina)
Por Legionella	Viajeros, torres de enfriamiento	Legionella pneumophila (intracelular)	Levofloxacino 750 mg/d o Azitromicina EV

REGLA DE ORO **Disociación clínico-radiológica** — Macrólido o doxiciclina

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **27–30** (pág. 13) · solucionario pág. 28.

Clase 2.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
2 preguntas reales 2013–2025

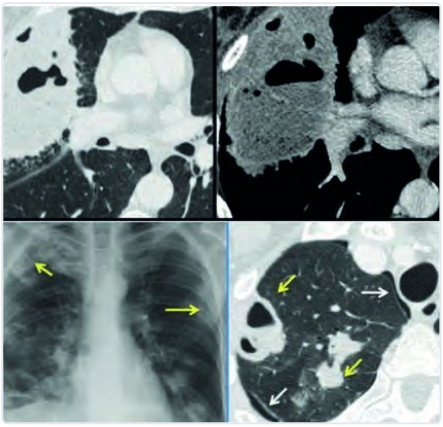
Media · Diagnóstico radiológico de cavidad con nivel hidroaéreo y manejo médico prolongado

1.05.1.001 Absceso pulmonar — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Supuración pulmonar · Fibrobroncoscopia

LO QUE TE PREGUNTAN

- El absceso pulmonar se caracteriza en la imagen por una cavidad de pared gruesa con nivel hidroaéreo.
- El **90%** se debe a aspiración de flora oral anaerobia en pacientes con mala higiene bucal o alcoholismo.
- El tratamiento estándar es médico con antibióticos por **4 a 6 semanas** (Ampicilina/Sulbactam o Amox/Clav).
- No se indica drenaje quirúrgico de rutina; la gran mayoría drena espontáneamente por el árbol bronquial.
- En fumadores mayores de **50 años** con lesión cavitada siempre debe sospecharse y descartarse cáncer broncogénico.



ABSCESO CON NIVEL
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 16

ALGORITMO · ABSCESO PULMONAR: DE LA SOSPECHA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

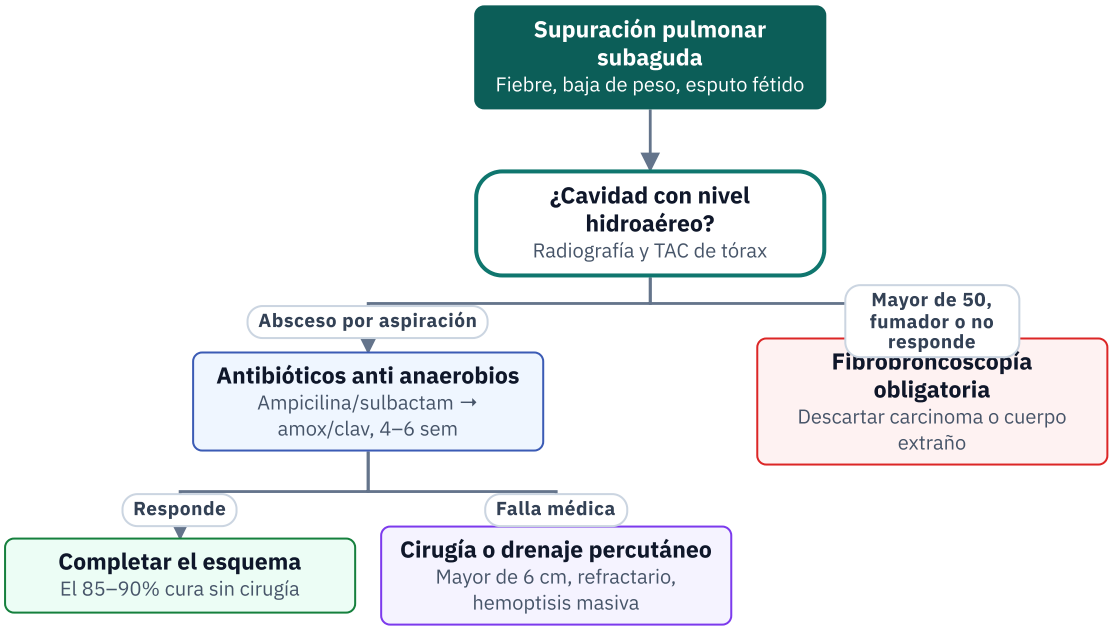


TABLA 2.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE LESIONES CAVITADAS EN TÓRAX

ENTIDAD CLÍNICA	PARED DE LA CAVIDAD	NIVEL HIDROAÉREO	LOCALIZACIÓN TÍPICA	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Absceso Pulmonar	Gruesa, regular por dentro	Frecuente y evidente	Segmentos dependientes (posteriores/apicales)	Ampicilina/Sulbactam oral/EV x 4-6 sem
Cáncer Pulmonar Cavitado	Muy gruesa (> 15 mm), nodular interna	Ocasional o ausente	Lóbulos superiores (carcinoma epidermoide)	Biopsia, estadificación y oncología
Tuberculosis Cavitada	Fina a moderada, halo retráctil	Raro	Segmentos apicales y posteriores superiores	Terapia 4 drogas (RHZE MINSAL)
Quiste Hidatídico Complicado	Fina con membrana desprendida	Signo del camalote / nenúfar	Bases pulmonares (más frec. derecha)	Albendazol + Cirugía conservadora

REGLA DE ORO **Alcohol + mala dentadura + esputo fétido** — Anaerobios orales aspirados

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **31–34** (págs. 13–14) · solucionario págs. 28–29.

Clase 2.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES

2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento

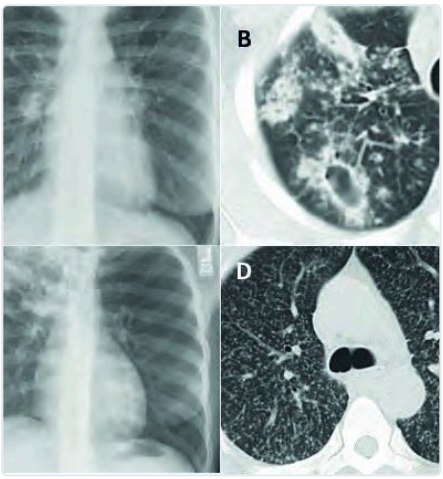
★★★ PRIORIDAD ALTA
17 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.036 Tuberculosis pulmonar — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Programa Nacional de Control de TBC · Baciloscopia y cultivo de Koch de expectoración · Profilaxis de tuberculosis · Cultivo de expectoración · Reacción de polimerasa en cadena · Vacunación (tuberculosis, influenza, Coronavirus SARS-CoV-2 y neumococo)

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Sintomático respiratorio**: persona con tos y expectoración por **≥ 2 semanas** (**15 días**).
- El GeneXpert MTB/RIF detecta en **2 horas** la presencia de M. tuberculosis y la resistencia a Rifampicina.
- **Esquema primario estándar**: **2 meses** de RHZE diario + **4 meses** de RH (**6 meses** totales).
- La TBC meníngea y osteoarticular exige prolongar la terapia a **12 meses** (2 RHZE + 10 RH) y asociar corticoides.
- El Etambutol causa neuritis óptica con alteración precoz de la discriminación de colores rojo y verde (discromatopsia).
- La Rifampicina tiñe secreciones y orina de color anaranjado y es un potente inductor hepático del CYP450.



CAVITACIÓN
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 14

ALGORITMO · TUBERCULOSIS: DE LA TOS A LOS CONTACTOS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

Tos con expectoración ≥ 15 días
Sintomático respiratorio

↓

¿GeneXpert o baciloscopía positivos?
Cultivo en todas las muestras

NO, con alta sospecha → **Esperar cultivo · TAC · broncoscopía**
Negativo no descarta

SÍ → **Notificar + estudiar contactos**
Tratamiento en el PROCET

- **Forma pulmonar** → **2 RHZE + 4 RH**
  6 meses, observado
- **Meníngea u osteoarticular** → **2 RHZE + 10 RH + corticoides**
  12 meses
- **Contacto menor de 5 o VIH, Rx normal** → **Terapia preventiva**
  Isoniazida 6 meses, sin esperar PPD

TABLA 2.5 · FÁRMACOS ANTITUBERCULOSOS DE PRIMERA LÍNEA Y TOXICIDAD ESPECÍFICA

FÁRMACO	MECANISMO DE ACCIÓN	PRINCIPAL EFECTO ADVERSO	PERLA EUNACOM
Isoniazida (H)	Inhibe síntesis de ácido micólico	Neuropatía periférica y hepatitis	Prevenir con Piridoxina (Vitamina B6)
Rifampicina (R)	Inhibe ARN polimerasa	Hepatotoxicidad e inductores CYP450	Tiñe orina y secreciones de color rojo-naranja
Pirazinamida (Z)	Altera energía y transporte en pH ácido	El más hepatotóxico e hiperuricemia	Puede desencadenar crisis de gota
Etambutol (E)	Inhibe arabinosil transferasa	Neuritis óptica retrobulbar	Pérdida de discriminación color rojo-verde

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

FÁRMACO	EFECTO ADVERSO TÍPICO	CONDUCTA / PERLA
Contacto < 5 años o VIH, Rx normal	Riesgo de TBC grave	Terapia preventiva sin esperar PPD

REGLA DE ORO — **Tos con expectoración ≥ 15 días** — Sintomático respiratorio: se estudia

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **35–36** (pág. 14) · solucionario pág. 29.

Clase 2.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light

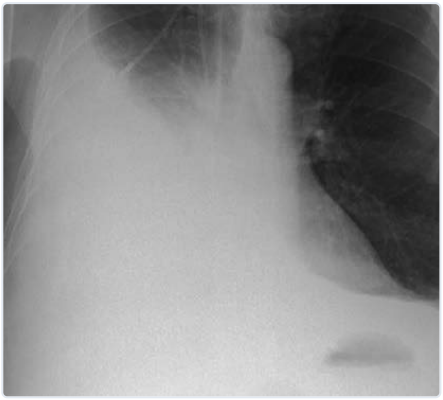
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

4.01.1.043 **Síndrome de ocupación pleural** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Citoquímico de líquido pleural · Punción pleural · Ecografía pleural

LO QUE TE PREGUNTAN

- Basta cumplir UN SOLO criterio de Light para certificar que el líquido pleural es un Exudado.
- **Los tres criterios de Light**: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.
- La causa más frecuente de trasudado pleural es la insuficiencia cardíaca descompensada.
- Las tres causas más frecuentes de exudado son el derrame paraneumónico, el cáncer y la tuberculosis.
- **Trampa**: el tromboembolismo pulmonar (TEP) puede presentarse tanto como trasudado como exudado (frecuentemente serohemático).



DERRAME PLEURAL
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

ALGORITMO · DERRAME PLEURAL: DE LIGHT A LA CAUSA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

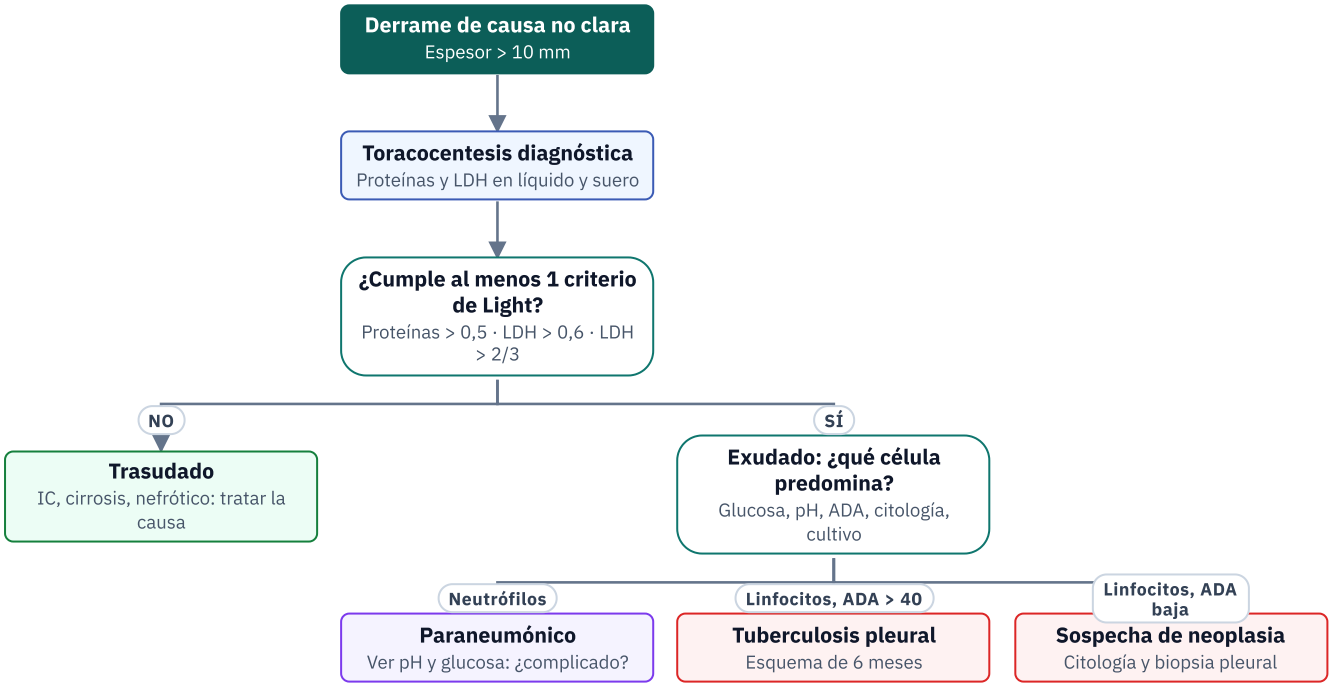


TABLA 3.1 · CRITERIOS DE LIGHT Y CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DEL LÍQUIDO PLEURAL

PARÁMETRO ANALÍTICO	TRASUDADO PLEURAL	EXUDADO PLEURAL	COMENTARIO EUNACOM
Mecanismo principal	Aumento presión hidrostática o baja coloidosmótica	Aumento de permeabilidad microvascular pleural	El trasudado no daña la pleura
Proteínas LP / Proteínas Suero	≤ 0.5	> 0.5	Basta 1 criterio positivo para exudado
LDH LP / LDH Suero	≤ 0.6	> 0.6	Muy sensible para inflamación activa
LDH absoluta LP	≤ 2/3 límite normal sérico	> 2/3 límite normal sérico	Habitualmente > 200 U/L en exudados
Causas habituales	Insuficiencia cardíaca, Cirrosis, Nefrótico	Paraneumónico, Cáncer, Tuberculosis, TEP	El TEP puede dar exudado o trasudado

REGLA DE ORO **Proteínas > 0,5 · LDH > 0,6 · LDH > 2/3** — Líquido y suero al mismo tiempo

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **38–40** (pág. 15) · solucionario pág. 29.

Clase 3.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural

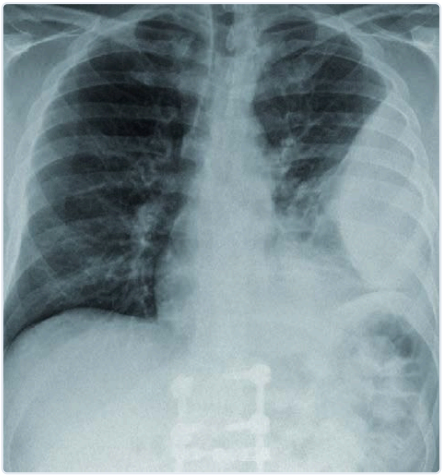
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.011 Derrame pleural paraneumónico complicado — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Derrame pleural paraneumónico simple · Drenaje pleural · Citoquímico de líquido pleural · Citoquímico de líquido cefaloraquídeo y pleural · Punción pleural · Examen microbiológico de líquido pleural

LO QUE TE PREGUNTAN

- El empiema se define por pus macroscópico franco O bacterias visibles en Gram/cultivo del líquido pleural.
- **Derrame paraneumónico complicado**: pH < 7.20, glucosa < **40-60 mg/dL** y LDH > **1.000 U/L**.
- Todo empiema o derrame paraneumónico complicado exige la instalación inmediata de un Tubo de Drenaje Torácico (pleurostomía).
- El pH del líquido pleural (< 7.20) es el parámetro bioquímico individual más sensible y específico para indicar drenaje con tubo.
- El tratamiento antibiótico empírico debe cubrir anaerobios orales (Ampicilina/Sulbactam o Ceftriaxona + Metronidazol) por **2 a 4 semanas**.
- Si existen tabicaciones múltiples en la ecografía que no drenan por el tubo, la conducta es fibrinolíticos intrapleurales (t-PA + DNAsa) o VATS.



DERRAME ENCAPSULADO
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 111

ALGORITMO · NEUMONÍA CON DERRAME: ¿ANTIBIÓTICO O TUBO?

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

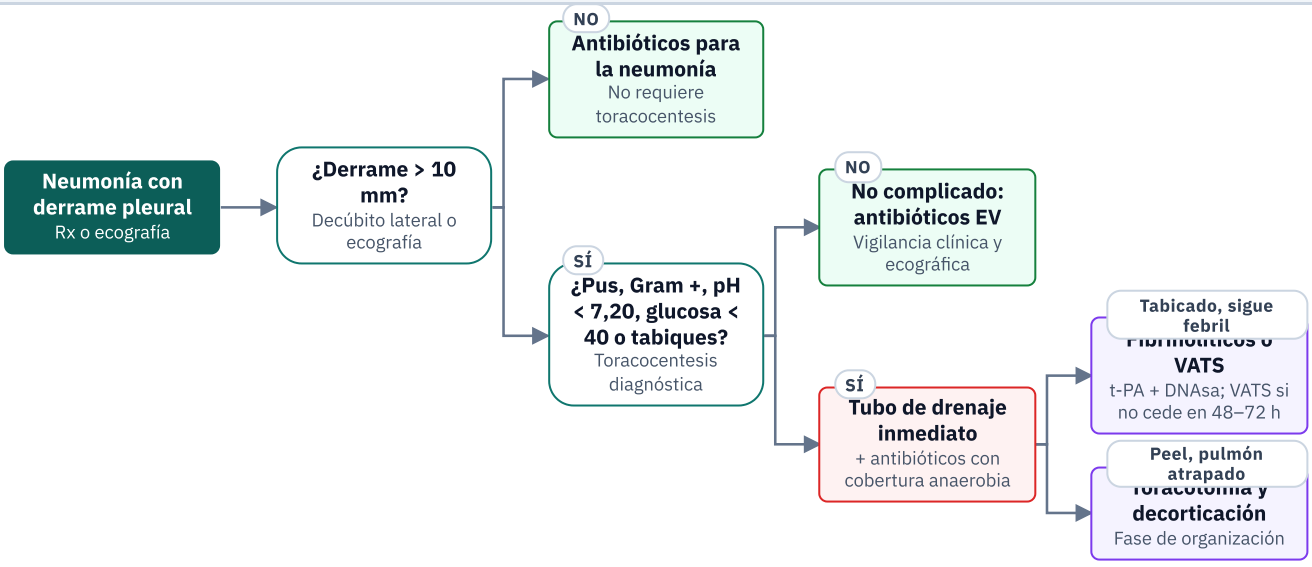


TABLA 3.2 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL BIOQUÍMICO DEL DERRAME PARANEUMÓNICO

PARÁMETRO	PARANEUMÓNICO NO COMPLICADO	PARANEUMÓNICO COMPLICADO	EMPIEMA PLEURAL
Aspecto macroscópico	Claro o turbio seroso	Turbio espeso	Purulento franco (pus macroscópico)
pH pleural	> 7.20	< 7.20	< 7.10 - 7.20
Glucosa pleural	> 60 mg/dL	< 40 - 60 mg/dL	< 40 mg/dL (frecuentemente 0-20)
LDH pleural	< 1.000 U/L	> 1.000 U/L	> 1.000 U/L (frecuente > 3.000)
Tinción Gram / Cultivo	Negativos	Negativos o positivos	Positivos en > 70%
Conducta EUNACOM	Solo antibióticos EV	Tubo de Drenaje Pleural Inmediato	Tubo de Drenaje Pleural Inmediato

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

PARÁMETRO	NO COMPLICADO	COMPLICADO	EMPIEMA
pH	> 7,20	< 7,20	< 7,10–7,20

REGLA DE ORO **Empiema: pus o Gram/cultivo +** — Complicado: pH < 7,20, glucosa < 40–60, LDH > 1.000

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **41–46** (págs. 15–16) · solucionario pág. 30.

Clase 3.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario

Alta · Criterios de tamaño y manejo expectante vs tubo de drenaje

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
3 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.031 Neumotórax moderado y grande — Dx Específico · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Neumotórax pequeño

LO QUE TE PREGUNTAN

- El neumotórax primario es típico de hombres jóvenes, delgados y fumadores por rotura de blebs apicales.
- El oxígeno suplementario a alto flujo acelera hasta **4 veces** la tasa de reabsorción del neumotórax.
- **Neumotórax primario pequeño (< 2 cm) y estable**: observación y oxígeno; no requiere punción ni tubo de entrada.
- Neumotórax secundario (en EPOC) casi siempre requiere pleurostomía con tubo de drenaje.
- La cirugía mediante VATS y pleurodesis se indica obligatoriamente ante un segundo episodio homolateral o fuga > **48-72 h**.



INSPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN
Manual CTO Radiología 14.ª ed., p. 23

ALGORITMO · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO: TIPO, TAMAÑO Y CIRUGÍA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

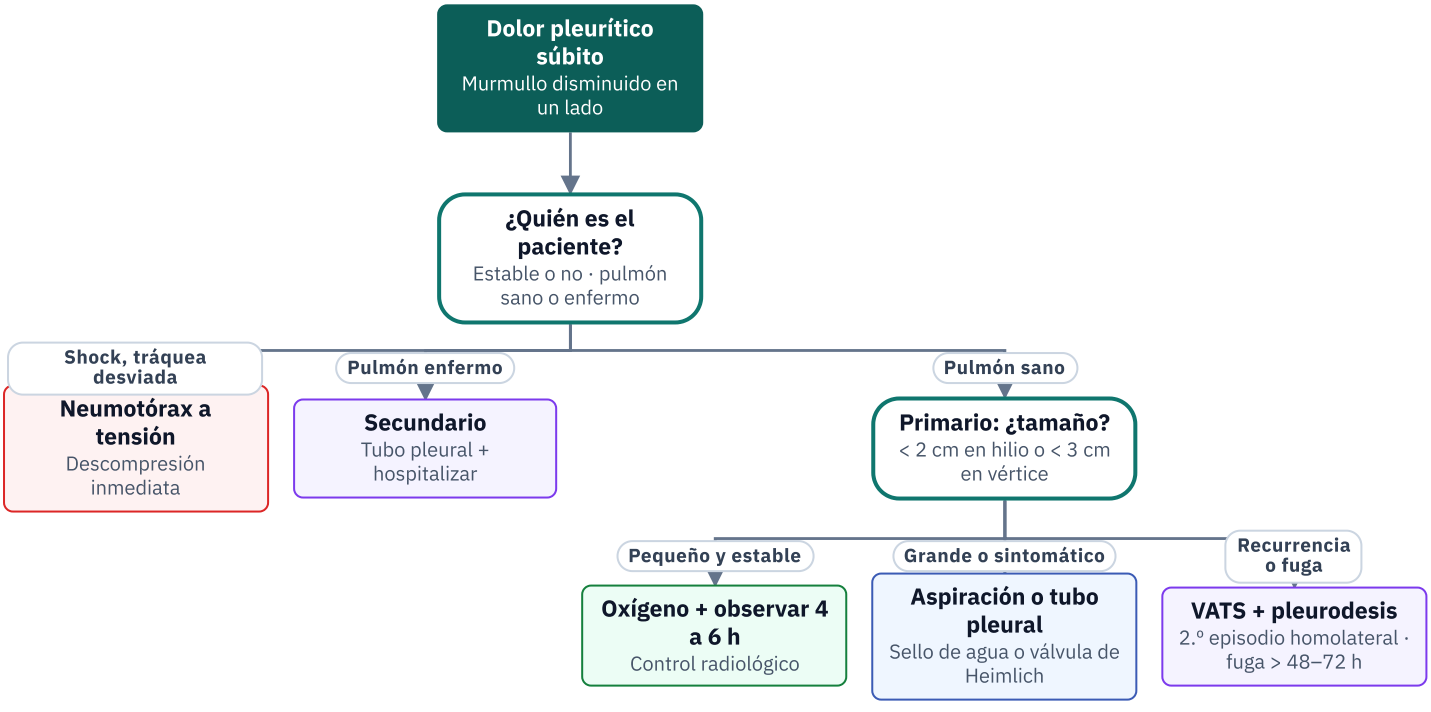


TABLA 3.3 · NEUMOTÓRAX ESPONTÁNEO PRIMARIO (NEP) VS SECUNDARIO (NES)

CARACTERÍSTICA	NEUMOTÓRAX PRIMARIO (NEP)	NEUMOTÓRAX SECUNDARIO (NES)
Población típica	Varón joven (20-30 años), alto, delgado, fumador	Adulto mayor (> 60 años) con patología pulmonar crónica
Enfermedad de base	Ninguna (rotura de blebs apicales)	EPOC (enfisema), fibrosis, TBC secuelar, P. jirovecii
Tolerancia clínica	Buena (disnea leve, dolor pleurítico)	Mala (insuficiencia respiratoria e inestabilidad frecuente)
Manejo si es pequeño	Observación + Oxígeno normobárico	Tubo de drenaje torácico obligatorio en casi 100%
Tasa de recurrencia	30% tras primer episodio, > 50% tras segundo	Mayor al 50% con alta mortalidad

REGLA DE ORO **Primario: joven, alto, delgado** — Blebs apicales, buena tolerancia

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **47–49** (pág. 16) · solucionario págs. 30–31.

Clase 3.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático

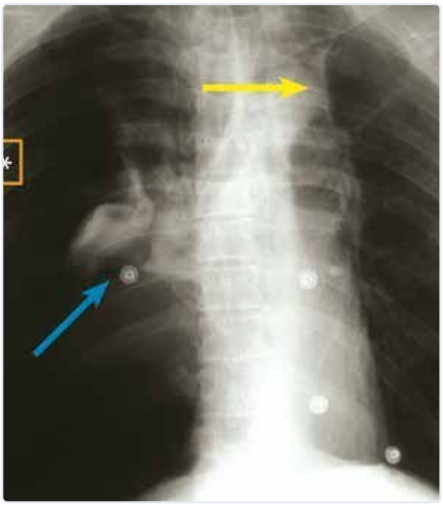
★☆☆
PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.05.2.011 Neumotórax hipertensivo — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Traumatismo torácico grave · Drenaje pleural

LO QUE TE PREGUNTAN

- El neumotórax a tensión es una emergencia médica con diagnóstico **100%** clínico; jamás se debe solicitar radiografía de tórax.
- **Semiología clásica**: shock obstructivo + ingurgitación yugular + hipersonoridad/timpanismo + desviación traqueal contralateral.
- **Manejo inmediato**: descompresión urgente con aguja gruesa 14-16G en 2° EIC línea medioclavicular o 5° EIC línea axilar anterior.
- La pleurostomía con tubo grueso de tórax (28-32 Fr) es el tratamiento definitivo obligatorio tras la descompresión con aguja.
- **Diferencia cardinal con hemotórax masivo**: el hemotórax cursa con matidez a la percusión y venas yugulares colapsadas por hipovolemia.
- **Criterios de toracotomía quirúrgica de urgencia en hemotórax**: drenaje inicial **≥ 1.500 mL** de sangre o débito continuo **≥ 200 mL/hora** por **2 a 4 horas**.



NEUMOTÓRAX A TENSIÓN
Manual CTO Cirugía 14.ª ed., p. 71

ALGORITMO · TRAUMA TORÁCICO EN SHOCK: QUÉ DICEN EL CUELLO Y LA PERCUSIÓN

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

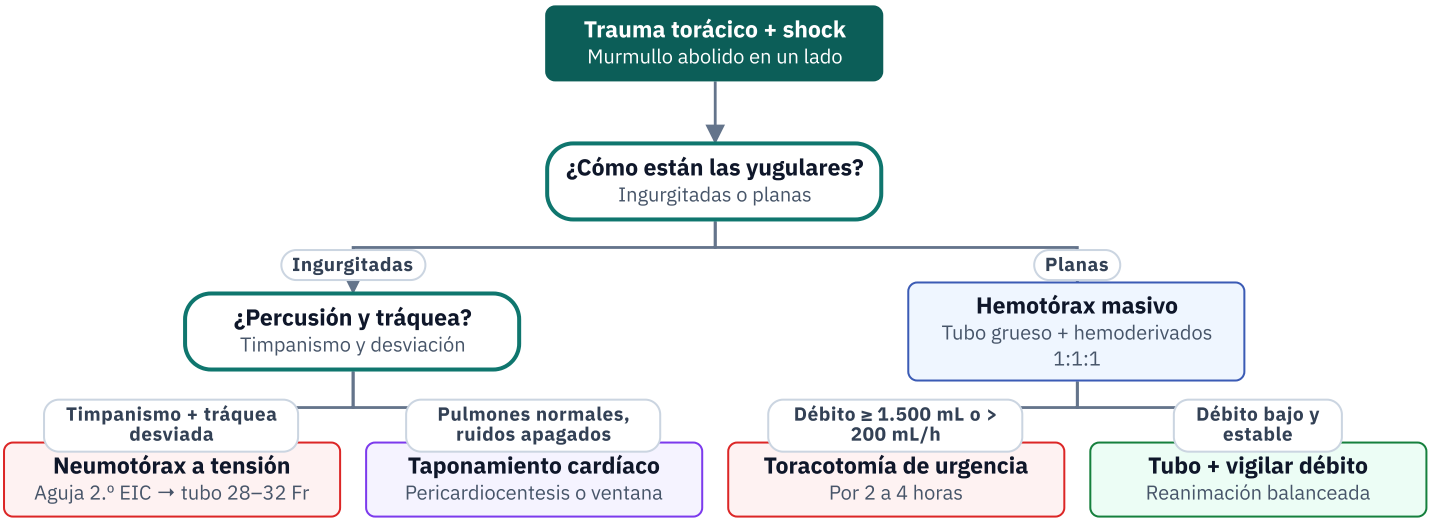


TABLA 3.4 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL EN URGENCIAS: NEUMOTÓRAX A TENSIÓN VS HEMOTÓRAX MASIVO VS TAPONAMIENTO

SIGNO CLÍNICO	NEUMOTÓRAX A TENSIÓN	HEMOTÓRAX MASIVO	TAPONAMIENTO CARDÍACO
Presión arterial	Shock profundo (obstructivo)	Shock hipovolémico grave	Hipotensión marcada (Tríada Beck)
Yugulares	Ingurgitadas a tensión	Planos / colapsados	Ingurgitadas a tensión
Percusión torácica	Hipersonoridad / Timpanismo	Matidez franca en base/hemitórax	Sonoridad pulmonar normal
Murmullo vesicular	Abolido ipsilateral	Disminuido o abolido ipsilateral	Murmullo pulmonar conservado bilateral
Posición traqueal	Desviada al lado contralateral	Centrada o leve desviación	Línea media estricta
Tratamiento de 1ª línea	Descompresión con aguja gruesa 14G	Tubo pleural + Hemoderivados	Pericardiocentesis o ventana pericárdica

REGLA DE ORO **Shock + yugulares + tráquea desviada** — Con timpanismo: no pidas radiografía

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **37, 50–53** (págs. 14, 16–17) · solucionario págs. 29, 31.

Clase 3.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS

3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa

Alta · Diagnóstico diferencial de exudados con predominio mononuclear

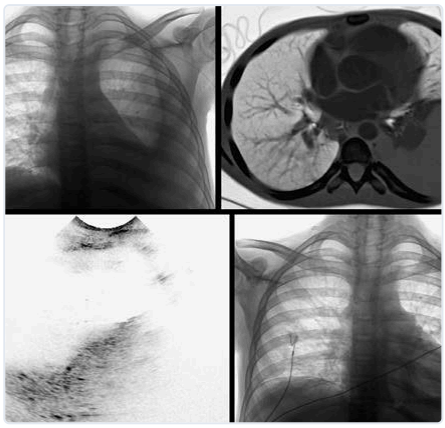
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
6 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.013 **Derrame pleural por tuberculosis** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Derrame pleural neoplásico · Biopsia pleural · Mesotelioma pleural

LO QUE TE PREGUNTAN

- Todo exudado pleural con > **50%** de linfocitos exige descartar Tuberculosis y Cáncer.
- Un ADA en líquido pleural **≥ 40 U/L** tiene altísima especificidad para pleuritis tuberculosa.
- La baciloscopía del líquido pleural tiene muy bajo rendimiento (< **10%**) en tuberculosis; la confirmación es por biopsia.
- La citología de líquido pleural diagnostica el **60%** de los derrames malignos en la primera muestra.
- El tratamiento del derrame neoplásico recidivante sintomático es la pleurodesis química con talco o catéter tunelizado.



DERRAME NEOPLÁSICO MASIVO
Nelson Textbook of Pediatrics, p. 3358

ALGORITMO · EXUDADO LINFOCÍTICO: TUBERCULOSIS O CÁNCER

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

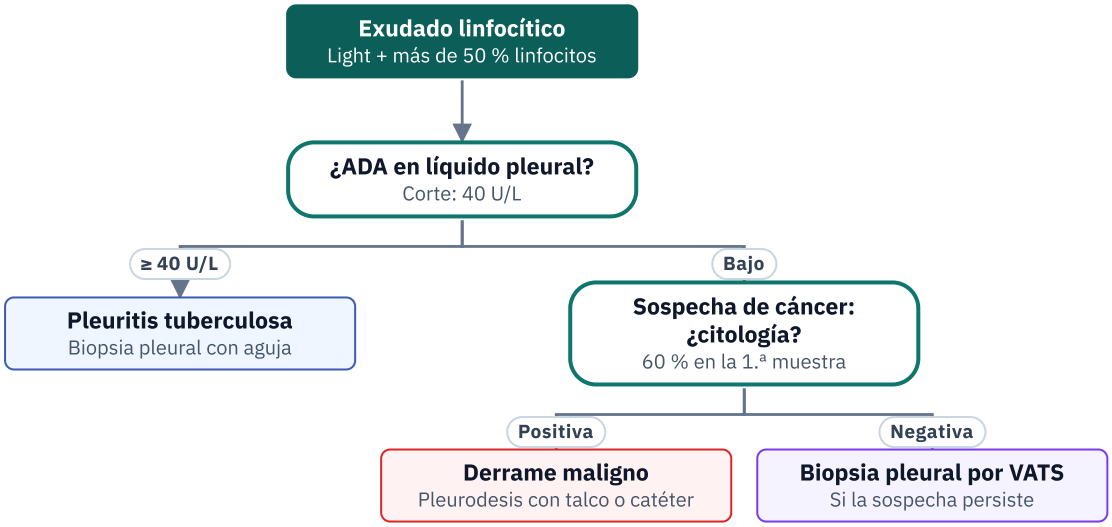


TABLA 3.5 · DIFERENCIACIÓN DIAGNÓSTICA: PLEURITIS TUBERCULOSA VS DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO

CARACTERÍSTICA	PLEURITIS TUBERCULOSA	DERRAME PLEURAL NEOPLÁSICO (MALIGNO)
Edad habitual	Jóvenes o adultos con inmunosenescencia	Adultos mayores (> 50-60 años)
Aspecto del líquido	Amarillo cetrino / serofibrinoso	Frecuentemente serohemático o hemorrágico
ADA pleural	Elevado: ≥ 40 U/L (típico > 45-50)	Bajo (< 35-40 U/L, salvo linfomas raros)
Baciloscopía directa LP	Muy baja sensibilidad (< 10%)	Negativa
Citología exfoliativa LP	Negativa para atipías	Positiva para células malignas en 60-80%
Biopsia pleural	Granulomas caseificantes (rendimiento > 80%)	Infiltración tumoral epitelial maligna
Manejo definitivo	Quimioterapia antituberculosa RHZE	Pleurodesis con talco o Catéter tunelizado (PleurX)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	TUBERCULOSIS PLEURAL	DERRAME NEOPLÁSICO
Tratamiento	Esquema antituberculoso	Pleurodesis con talco o catéter

REGLA DE ORO — **Linfocitos > 50 %: TBC o cáncer** — El ADA decide la sospecha

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, pregunta **54** (pág. 17) · solucionario pág. 32.

Clase 3.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner

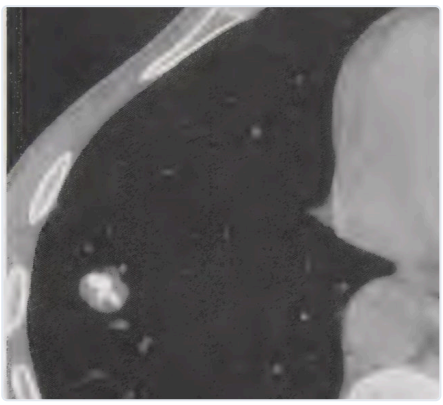
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.038 Nódulos pulmonares — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Nódulo pulmonar solitario · TAC de tórax · Metástasis pulmonares

LO QUE TE PREGUNTAN

- La primera medida obligatoria ante un nódulo pulmonar solitario es comparar con radiografías o TACs previas.
- Un nódulo con estabilidad documentada de tamaño y forma por **≥ 2 años** es benigno en el **99%** de los casos.
- La calcificación en "popcorn" (palomitas de maíz) es diagnóstica y patognomónica de hamartoma pulmonar.
- Bordes espiculados, tamaño > **8 mm** y localización en lóbulo superior indican alta sospecha de cáncer.
- En nódulos > **8 mm** con riesgo intermedio el examen no invasivo de elección es el PET-CT con 18-FDG.



HAMARTOMA CON POPCORN
Brant y Helms, Fundamentals of Diagnostic Radiology, p. 461

ALGORITMO · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: DEL HALLAZGO A LA CONDUCTA

urgencia | resuelve | derivar | examen/acción

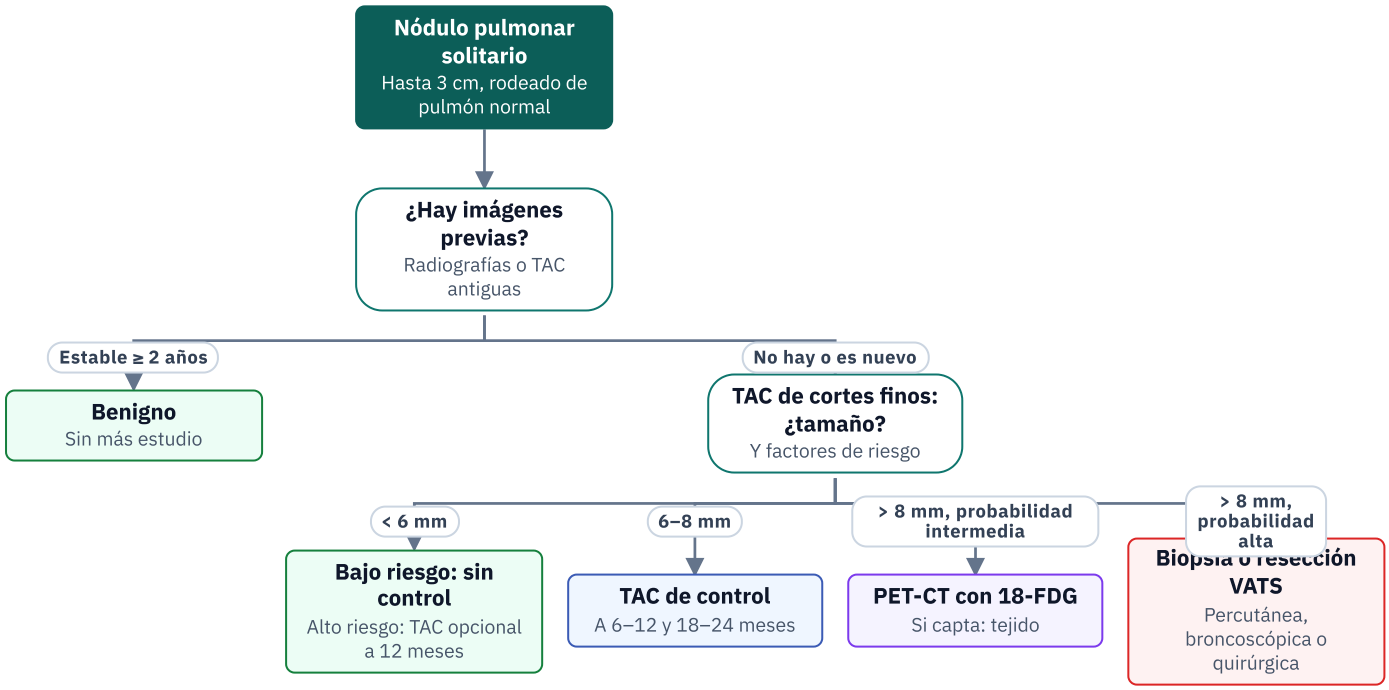


TABLA 4.1 · NÓDULO PULMONAR SOLITARIO: SIGNOS RADIOLÓGICOS BENIGNOS VS MALIGNOS

CARACTERÍSTICA	ALTA PROBABILIDAD DE BENIGNIDAD	ALTA PROBABILIDAD DE MALIGNIDAD
Tamaño	< 6 mm (estable por ≥ 2 años)	> 8 - 10 mm (o crecimiento en controles)
Márgenes / Bordes	Lisos, netos, regulares y definidos	Espiculados, irregulares, corona radiada
Patrón de calcificación	Central, concéntrico o en popcorn (hamartoma)	Ausente, excéntrica, punteada o amorfa
Densidad radiológica	Sólida homogénea / grasa macroscópica	Parcialmente sólido (sub-sólido / vidrio esmerilado)
Localización	Cualquiera (frecuente periférico basal)	Predominio en lóbulos superiores
Conducta estándar	Comparar con previas / Observación	PET-CT, Biopsia percutánea o Resección VATS

REGLA DE ORO **Primero: imágenes previas** — Estable 2 años o más: benigno

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **56–57** (págs. 17–18) · solucionario pág. 32.

Clase 4.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial

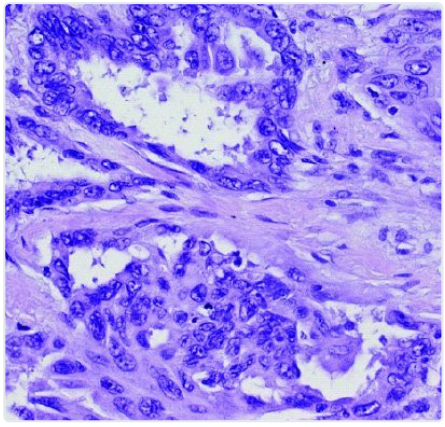
★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.007 **Cáncer bronquial primario** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Cáncer pulmonar · Síndromes mediastínicos · Síndrome paraneoplásico · Síndrome vena cava superior · Tumores primarios y metastásicos SNC

LO QUE TE PREGUNTAN

- El adenocarcinoma es el más frecuente en la población general y el más habitual en mujeres no fumadoras (periférico).
- El carcinoma epidermoide es central, tiende a cavitar y produce hipercalcemia tumoral mediada por PTHrP.
- El carcinoma microcítico es central, muy agresivo, no quirúrgico y causa SIADH, Cushing ectópico y Lambert-Eaton.
- **Tumor de Pancoast**: dolor en territorio C8-T1 más Síndrome de Horner ipsilateral (ptosis, miosis, anhidrosis).
- El tratamiento curativo del cáncer no microcítico en estadios resecables (I y II) es la lobectomía quirúrgica reglada.



ADENOCARCINOMA
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 125

ALGORITMO · CÁNCER PULMONAR: DE LA MASA A LA CONDUCTA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

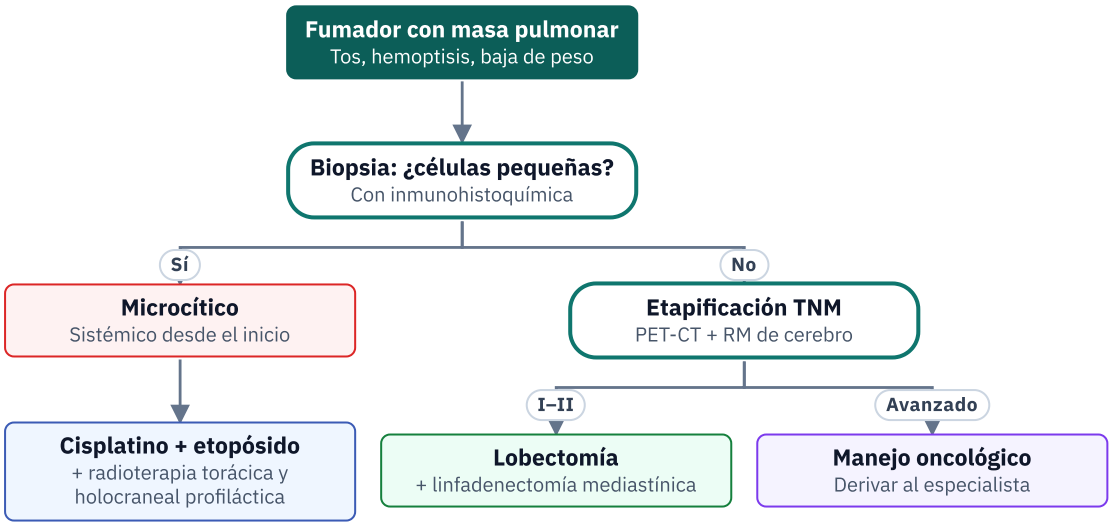


TABLA 4.2 · TIPOS HISTOLÓGICOS DE CÁNCER PULMONAR Y SUS SÍNDROMES PARANEOPLÁSICOS

TIPO HISTOLÓGICO	FRECUENCIA Y UBICACIÓN	ASOCIACIÓN TABACO	SÍNDROME PARANEOPLÁSICO / HALLAZGO
Adenocarcinoma	40-50% · Periférico	Fumadores y No fumadores	Osteoartropatía hipertrófica / Acropaquia
Carcinoma Epidermoide	25-30% · Central	Fuerte asociación (cavitado)	Hipercalcemia humoral por PTHrP
Carcinoma Microcítico	15% · Central (perihiliar)	Casi 100% fumadores pesados	SIADH (hiponatremia), Cushing (ACTH), Lambert-Eaton
Células Grandes	10% · Periférico	Fumadores	Ginecomastia (secreción beta-HCG)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

TIPO	UBICACIÓN Y FRECUENCIA	FIRMA DE EXAMEN
Microcítico localizado	Quimio + radioterapia	Error: operarlo
No microcítico etapa I–II	Lobectomía + linfadenectomía	Error: solo quimioterapia

REGLA DE ORO **Microcítico: nunca cirugía** — Cisplatino + etopósido + radioterapia

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **55, 58–62** (págs. 17–18) · solucionario págs. 32–33.

Clase 4.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática

★★★ PRIORIDAD ALTA
9 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.018 **Enfermedades del intersticio pulmonar** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Daño pulmonar secundario a drogas · Neumoconiosis · Prevención de daño pulmonar por inhalantes domésticos y laborales

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Semiología clásica de FPI**: estertores crepitantes secos tipo velcro bibasales + acropaquia.
- El patrón tomográfico en la TACAR que define a la FPI es la Neumonía Intersticial Usual (NIU) con panal de abejas.
- Si la TACAR muestra patrón NIU típico en un paciente > **60 años**, NO se requiere biopsia pulmonar.
- **Trampa de examen**: los corticoides y azatioprina están contraindicados en FPI (aumentan la mortalidad).
- El tratamiento específico de la FPI son los fármacos antifibróticos: Pirfenidona o Nintedanib.



ACROPAQUIAS
Manual AMIR Reumatología, p. 113

ALGORITMO · ENFERMEDAD INTERSTICIAL: EL PATRÓN MANDA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

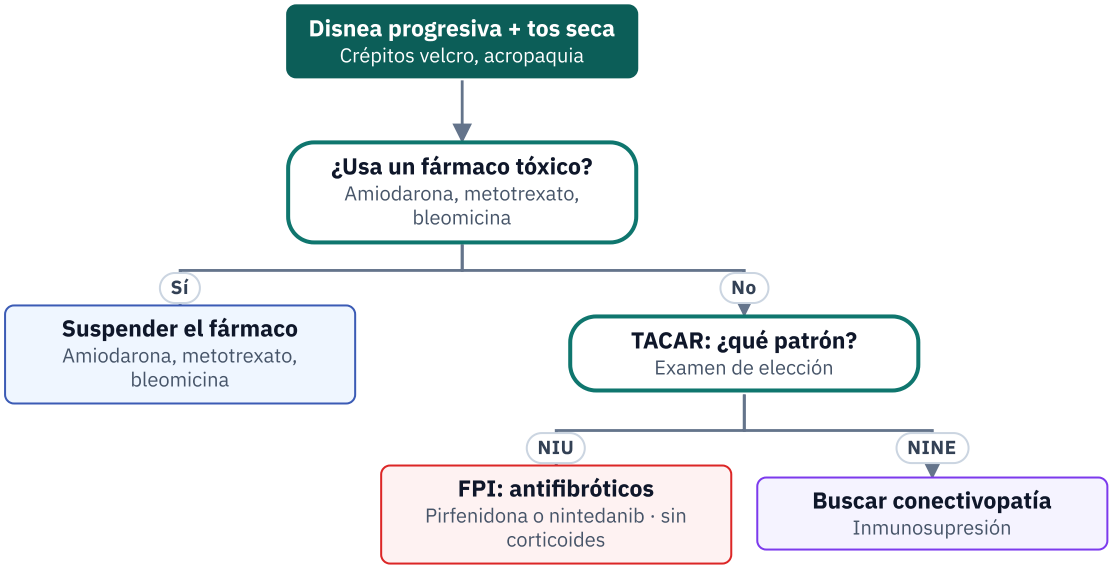


TABLA 4.3 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: PATRÓN NIU (FIBROSIS IDIOPÁTICA) VS PATRÓN NINE (CONECTIVOPATÍAS)

CARACTERÍSTICA	PATRÓN NIU (FIBROSIS PULMONAR IDIOPÁTICA)	PATRÓN NINE (ASOCIADO A CONECTIVOPATÍAS)
Población habitual	Hombres > 60-65 años, fumadores	Mujeres jóvenes a maduras, no fumadoras
Hallazgo tomográfico clave	Panal de abejas subpleural basal + Tracción	Vidrio esmerilado predominante homogéneo
Afección subpleural	Afecta la pleura visceral inmediata	Típicamente respeta el margen subpleural
Respuesta a Corticoides	Nula / Dañina (contraindicados)	Favorable a corticoides e inmunosupresores
Tratamiento específico	Antifibróticos (Pirfenidona / Nintedanib)	Inmunosupresión (Micofenolato, Azatioprina)

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

CARACTERÍSTICA	NIU (FPI)	NINE (CONECTIVOPATÍAS)
Paciente típico	Hombre > 60–65 años, fumador	Mujer joven a madura, no fumadora
Zona subpleural	Comprometida	Típicamente respetada
NIU definitivo > 60 años	Diagnóstico sin biopsia	Error: pedir biopsia

REGLA DE ORO — **Velcro + acropaquia** — Con disnea progresiva y tos seca

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **63–66** (págs. 18–19) · solucionario pág. 33.

Clase 4.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación

★★★ PRIORIDAD ALTA
15 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.015 Embolia pulmonar — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Embolia pulmonar masiva · TAC de tórax · Actividad física en pacientes con riesgo de trombosis

LO QUE TE PREGUNTAN

- En probabilidad clínica baja o intermedia de TEP (Wells **≤ 4**), el Dímero D negativo descarta la enfermedad con VPN > **99%**.
- En probabilidad clínica alta de TEP (Wells > 4), está formalmente contraindicado pedir Dímero D; se solicita Angio-TAC directo.
- El Angio-TAC de arterias pulmonares con contraste es el estándar de oro imagenológico en la práctica clínica actual.
- El TEP de alto riesgo (masivo) se define exclusivamente por inestabilidad hemodinámica (PAS < **90 mmHg** o shock obstructivo).
- **Tratamiento de elección en TEP de alto riesgo con shock**: Trombolisis sistémica urgente con rtPA (Alteplasa **100 mg** EV en **2 horas**).



TROMBOSIS VENOSA PROFUNDA
Wikimedia Commons, CC BY-SA 3.0

ALGORITMO · TEP: PRIMERO LA PRESIÓN, DESPUÉS WELLS

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

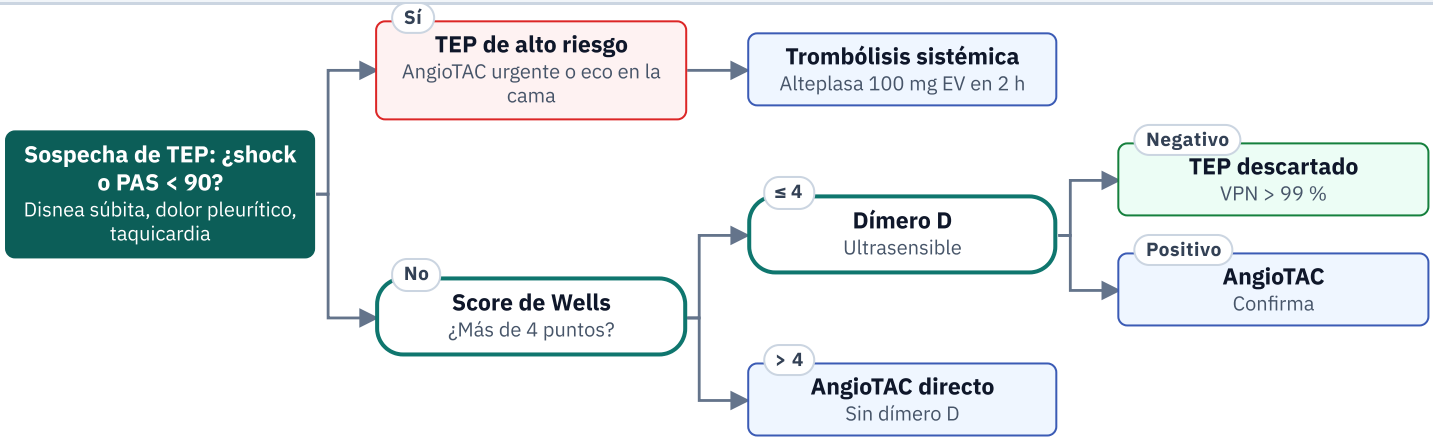


TABLA 4.4 · ESTRATIFICACIÓN DE RIESGO Y TRATAMIENTO DEL TEP AGUDO (GUÍAS ESC)

ESTRATO DE RIESGO	HEMODINAMIA	DISFUNCIÓN VD / TROPONINAS	TRATAMIENTO DE ELECCIÓN
Alto Riesgo (Masivo)	Shock o PAS < 90 mmHg persistente	Positivos (compromiso ventricular)	Trombolisis sistémica de urgencia (rtPA 100 mg EV)
Riesgo Intermedio-Alto	Normotenso (estable)	VD dilatado en eco Y Troponinas elevadas	Anticoagulación plena + Monitorización en UTI
Riesgo Intermedio-Bajo	Normotenso (estable)	Solo 1 positivo (eco o troponinas)	Anticoagulación plena en sala general
Bajo Riesgo	Normotenso (estable)	Ambos negativos (eco y troponinas normales)	Anticoagulación oral (ACOD) con alta precoz

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Estable, Wells ≤ 4	Dímero D ultrasensible	AngioTAC de entrada
Estable, Wells > 4	AngioTAC directo	Pedir dímero D
Shock o PAS < 90	Trombólisis: alteplasa 100 mg EV en 2 h	Solo heparina en sala

REGLA DE ORO **Shock o PAS < 90 = alto riesgo** — Trombólisis: alteplasa 100 mg en 2 h

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **67–69** (pág. 19) · solucionario págs. 33–34.

Clase 4.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR

4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias

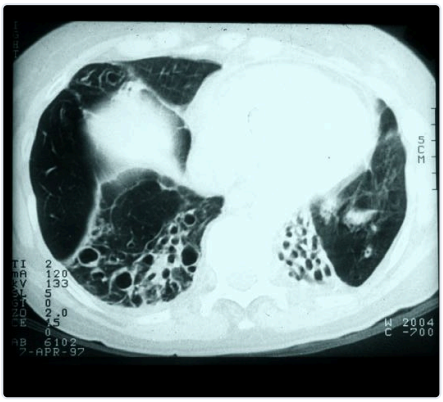
★★★ PRIORIDAD ALTA
7 preguntas reales 2013–2025

1.05.2.007 Hemoptisis moderada,severa y masiva — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Hemoptisis leve y mediana · Bronquiectasias · Hemoptisis masiva · Test del sudor

LO QUE TE PREGUNTAN

- En la hemoptisis masiva la causa de muerte es la asfixia por inundación alveolar, no el shock hemorrágico.
- **Medida postural inmediata**: decúbito lateral sobre el lado que sangra para proteger el pulmón sano de la aspiración.
- El **90%** de las hemoptisis masivas proviene de las arterias bronquiales sistémicas a alta presión.
- El procedimiento intervencional de elección para detener el sangrado es la embolización arterial bronquial.
- El examen de elección para confirmar bronquiectasias es la TACAR, que muestra el "signo del anillo de sello".



BRONQUIECTASIAS
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 68

ALGORITMO · HEMOPTISIS: PRIMERO LA VÍA AÉREA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

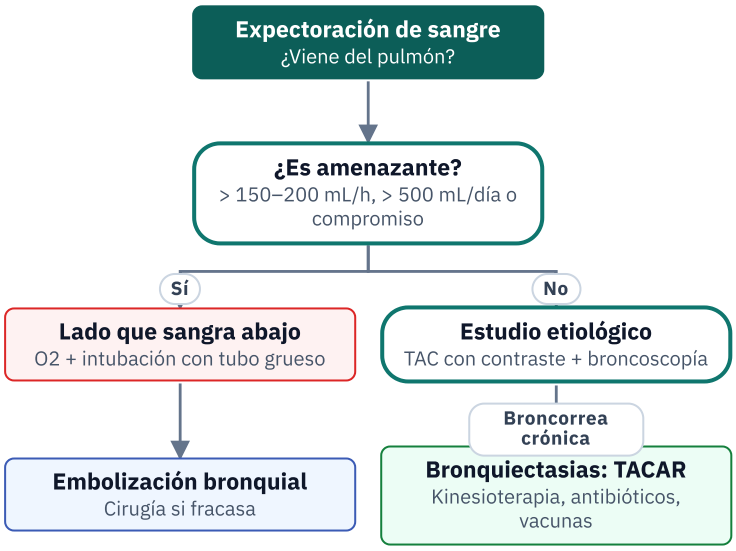


TABLA 4.5 · DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL: HEMOPTISIS VS HEMATEMESIS

CARACTERÍSTICA	HEMOPTISIS	HEMATEMESIS
Mecanismo de expulsión	Tos y carraspeo	Náuseas y vómitos
Color y aspecto	Rojo rutilante brillante, espumosa	Rojo oscuro, pardo ("concho de café"), no espumosa
pH químico	Alcalino	Ácido
Contenido asociado	Mucus respiratorio, macrófagos alveolares	Restos alimentarios
Pródromos	Cosquilleo laringofaríngeo, opresión torácica	Dolor epigástrico, náuseas
Etiologías comunes	Bronquiectasias, Cáncer, TBC, Aspergiloma	Úlcera péptica, Várices esofágicas, Mallory-Weiss

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Hemoptisis masiva del pulmón derecho	Decúbito lateral derecho	Lado sano abajo o Trendelenburg
Prioridad en la masiva	Proteger la vía aérea	Reponer volumen primero
Intubación	Tubo grueso ≥ 8,0 mm	Tubo delgado

REGLA DE ORO **Se muere de asfixia** — No de shock

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **70–72** (págs. 19–20) · solucionario pág. 34.

Clase 4.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.05.2.008 Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada que requiere ventilación mecánica — Dx Específico | Tx Inicial | Seg Derivar

También: Gases en sangre arterial · Ventilación mecánica no invasiva · Ventilación mecánica invasiva · Manejo ventilatorio básico · Traqueostomía y cricoidostomía · Insuficiencia respiratoria aguda · Insuficiencia respiratoria crónica · Insuficiencia respiratoria aguda o crónica reagudizada, que no requiere ventilación mecánica · Intubación traqueal · Aspiración traqueal

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Definición gasométrica de IRA**: PaO2 < **60 mmHg** respirando aire ambiental a nivel del mar (SatO2 < **90%**).
- IRA Tipo 1 es hipoxémica (PaCO2 **≤ 45 mmHg**) con Gradiente Alvéolo-Arterial elevado por daño parenquimatoso o vascular.
- IRA Tipo 2 es hipercápnica (PaCO2 > **45 mmHg**) secundaria a falla de bomba ventilatoria o fatiga muscular.
- La hipoventilación alveolar pura se diagnostica por hipercapnia con Gradiente Alvéolo-Arterial NORMAL (< **15–20 mmHg**).
- El Shunt intrapulmonar (SDRA, edema alveolar masivo) es el único mecanismo que NO corrige con O2 al **100%**.
- La Mascarilla Venturi es de elección en pacientes retenedores de CO2 para evitar hipoventilación por exceso de FiO2.

ALGORITMO · INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA: DE LOS GASES AL SOPORTE

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

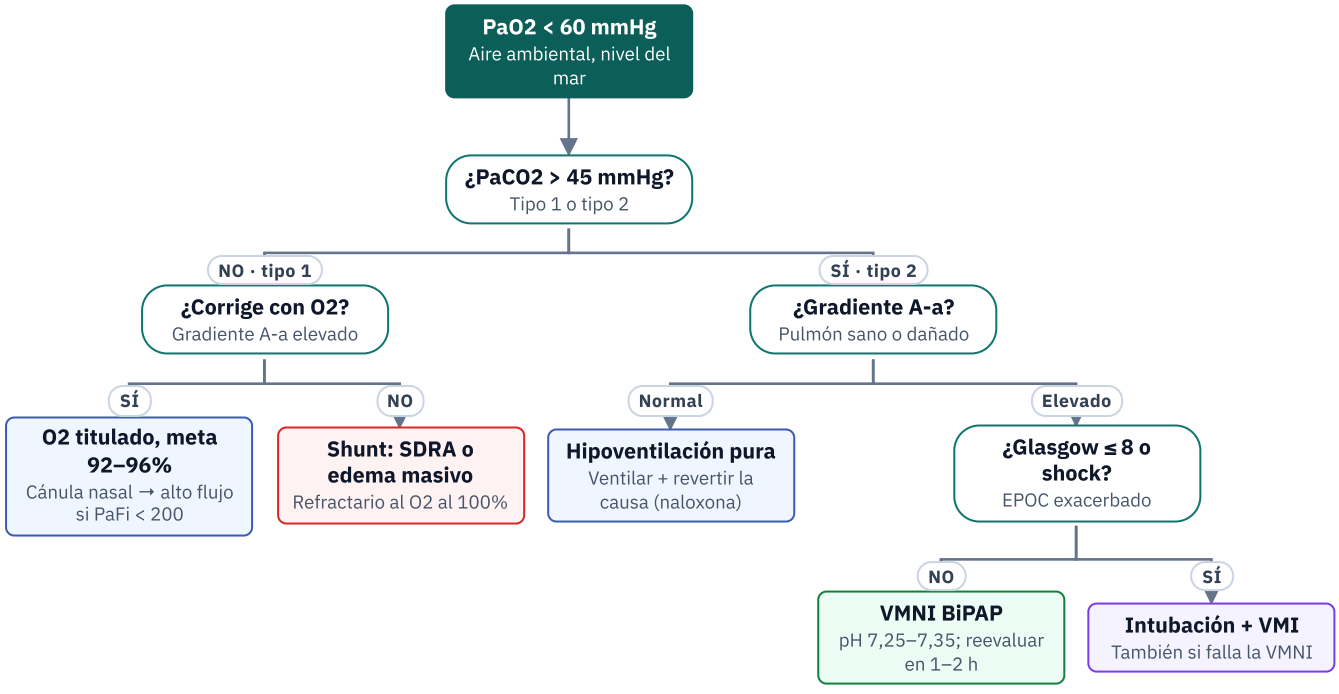


TABLA 5.1 · MECANISMOS FISIOPATOLÓGICOS DE LA INSUFICIENCIA RESPIRATORIA AGUDA

MECANISMO FISIOPATOLÓGICO	PAO2	PACO2	GRADIENTE A-A O2	RESPUESTA A O2 100%
Hipoventilación alveolar pura (Opioides, ACV)	Disminuida	Elevada (> 45)	NORMAL (< 15-20)	Corrige rápidamente
Desbalance V/Q bajo (NAC, EPOC, Asma)	Disminuida	Normal o Baja	ELEVADO (> 20)	Corrige fácilmente
Shunt Intrapulmonar (SDRA, Edema cardiogénico)	Muy disminuida	Normal o Baja	MUY ELEVADO	REFRACTARIO a O2 100%
Alteración de la Difusión (EPID avanzada)	Baja en esfuerzo	Normal o Baja	ELEVADO	Corrige con O2

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

MECANISMO	PACO2	GRADIENTE A-A	O2 AL 100%
Baja PiO2 (altura > 3.000 m)	Baja	Normal	Corrige

REGLA DE ORO **IRA = PaO2 < 60 mmHg** — Aire ambiental, nivel del mar

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **75–81** (págs. 20–21) · solucionario págs. 35–36.

Clase 5.1 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín

★☆☆ PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

1.05.1.014 **Edema pulmonar no cardiogénico** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Ventilación mecánica invasiva · Radiografía de tórax · Enfermedad grave por SARS Cov 2 COVID 19

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Criterios de Berlín**: inicio en **≤ 7 días**, opacidades bilaterales, edema no cardiogénico y PaFiO2 con PEEP **≥ 5.**
- **Estratificación de Berlín**: Leve (PaFi 200-300), Moderada (PaFi 100-200) y Severa (PaFi **≤ 100 mmHg**).
- La ventilación protectora exige volumen corriente bajo de **6 mL/kg** según peso corporal IDEAL (no real).
- La presión meseta o plateau debe mantenerse siempre en **≤ 30 cmH**2O para prevenir barotrauma.
- En SDRA severo con PaFiO2 < **150 mmHg**, la posición decúbito prono por **≥ 16 h/día** reduce significativamente la mortalidad.



DISTRÉS (SDRA)
Manual CTO Neumología 14.ª ed., p. 35

ALGORITMO · SDRA: DIAGNÓSTICO DE BERLÍN Y VENTILACIÓN PROTECTORA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

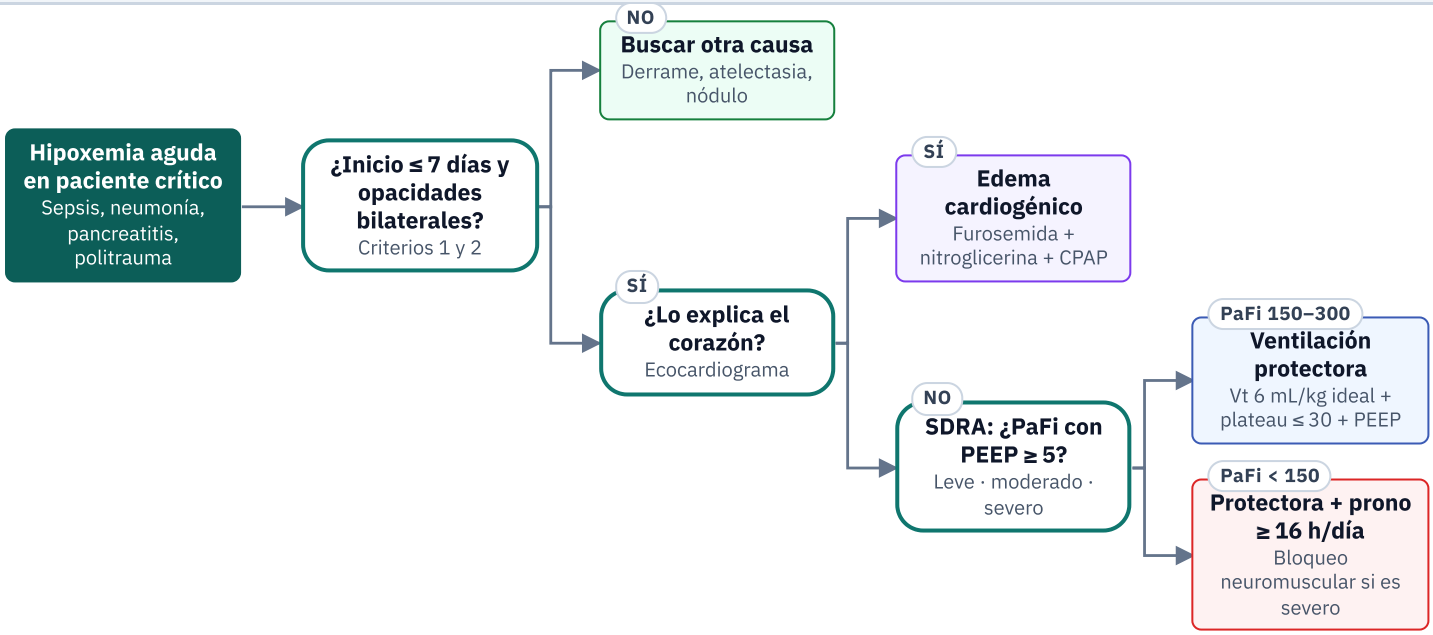


TABLA 5.2 · CLASIFICACIÓN DE BERLÍN DEL SÍNDROME DE DISTRÉS RESPIRATORIO AGUDO (SDRA)

CATEGORÍA SDRA	RELACIÓN PAFIO2 (CON PEEP ≥ 5)	MORTALIDAD ESTIMADA	INTERVENCIÓN DE IMPACTO COMPROBADO
Leve	200 < PaFiO2 ≤ 300 mmHg	27%	Ventilación protectora (Vt 6 mL/kg ideal)
Moderado	100 < PaFiO2 ≤ 200 mmHg	32%	PEEP optimizado + Evitar balance hídrico positivo
Severo	PaFiO2 ≤ 100 mmHg	45%	Posición Prono precoz (≥ 16 h/d) + Bloqueo neuromuscular

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
PaFi medida sin PEEP	Medir con PEEP o CPAP ≥ 5	Clasificar con cualquier PaFi
Opacidades bilaterales + falla cardíaca	Edema cardiogénico: diurético	Llamarlo SDRA
Volumen corriente	6 mL/kg de peso ideal	Calcular con el peso real

REGLA DE ORO **≤ 7 días + opacidades bilaterales** — No explicado por el corazón

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **82–83** (págs. 21–22) · solucionario pág. 36.

Clase 5.2 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)

★★☆ PRIORIDAD MEDIA
5 preguntas reales 2013–2025

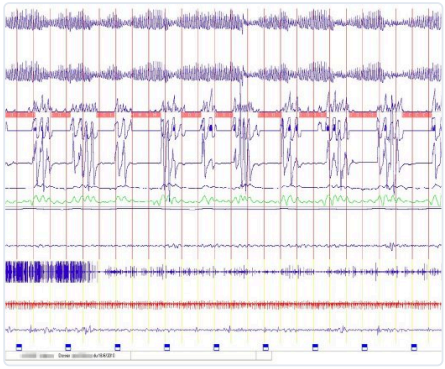
Alta · Diagnóstico por Polisomnografía e indicación de CPAP nocturno

1.05.1.033 **Síndrome de apnea del sueño** — Dx Sospecha · Tx Inicial · Seg Derivar

También: Polisomnografía

LO QUE TE PREGUNTAN

- **Tríada cardinal del SAHOS**: ronquidos intensos + apneas presenciadas + somnolencia diurna excesiva.
- El principal factor de riesgo modificable para SAHOS es la obesidad (IMC > **30 kg**/m²).
- El examen confirmatorio de referencia indiscutido es la Polisomnografía nocturna.
- El punto de corte de IAH para clasificar SAHOS moderado a severo e indicar CPAP es IAH **≥ 15 eventos/hora**.
- El tratamiento médico de primera línea es el CPAP nasal nocturno; los sedantes y el alcohol están contraindicados.



POLISOMNOGRAFÍA REAL
Wikimedia Commons «Polysomnographie-apnees-5min2.png», CC BY-SA 3.0, GAllegre

ALGORITMO · SAHOS: DE LA SOSPECHA AL CPAP

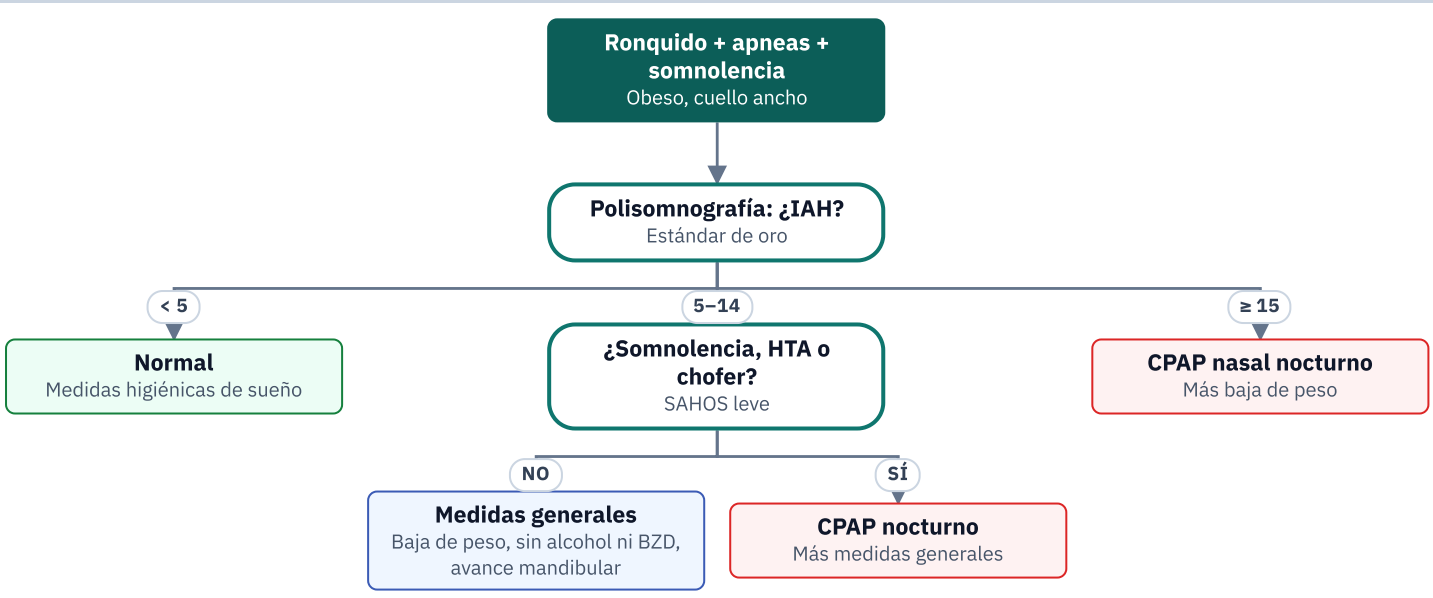


TABLA 5.3 · CLASIFICACIÓN DE SEVERIDAD Y ENFOQUE TERAPÉUTICO EN SAHOS

SEVERIDAD DEL SAHOS	ÍNDICE DE APNEA-HIPOAPNEA (IAH)	MANIFESTACIÓN TÍPICA	CONDUCTA TERAPÉUTICA RECOMENDADA
Normal	< 5 eventos / hora	Sin patología respiratoria nocturna	Medidas higiénicas generales de sueño
Leve	5 a 14 eventos / hora	Ronquido leve, somnolencia ocasional	Baja de peso, evitar alcohol/BZD, dispositivo avance mandibular
Moderado	15 a 29 eventos / hora	Somnolencia diurna habitual, microdespertares	CPAP nocturno continuo (tratamiento de 1.ª línea)
Severo	≥ 30 eventos / hora	Hipersomnia severa, riesgo vital vascular	CPAP nocturno continuo obligatorio + Control HTA

REGLA DE ORO **Ronquido + apneas + somnolencia** — En obeso de cuello ancho

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **84–86** (pág. 22) · solucionario pág. 36.

Clase 5.3 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo

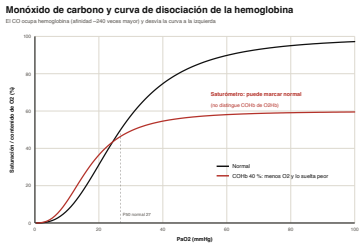
★★☆ PRIORIDAD MEDIA
4 preguntas reales 2013–2025

1.05.2.010 **Intoxicación por monóxido de carbono** — Dx Específico | Tx Completo | Seg Completo

También: Intoxicación leve por CO y otros gases · Saturometría arterial · Contaminación ambiental

LO QUE TE PREGUNTAN

- La oximetría de pulso estándar NO sirve para diagnosticar intoxicación por CO; marca falsamente **100%**.
- El examen confirmatorio es la medición de Carboxihemoglobina (COHb) por Co-oximetría en gases sanguíneos.
- El tratamiento inmediato de primera línea es Oxígeno al **100%** con mascarilla con reservorio por al menos **6 horas**.
- El O2 al **100%** normobárico reduce la vida media de la COHb de **320 minutos** a solo **80 minutos**.
- **Indicaciones de Oxígeno Hiperbárico**: COHb > **25%**, embarazadas con COHb > **15%**, síncope/coma o isquemia miocárdica.



CURVA DE DISOCIACIÓN
Dibujo propio (esquema)

ALGORITMO · MONÓXIDO DE CARBONO: DE LA SOSPECHA A LA CÁMARA

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

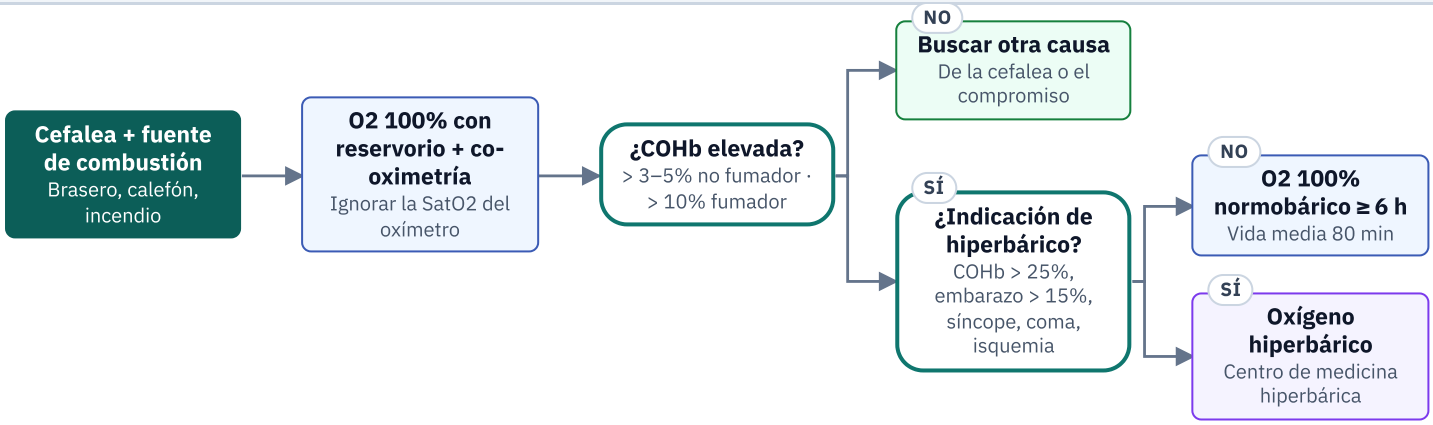


TABLA 5.4 · CINÉTICA DE ELIMINACIÓN DE LA CARBOXIHEMOGLOBINA Y TIEMPOS DE VIDA MEDIA

MODALIDAD DE OXIGENOTERAPIA	PRESIÓN Y FRACCIÓN DE O2	VIDA MEDIA DE LA COHB	LUGAR DE ADMINISTRACIÓN
Aire Ambiental	1 ATA (FiO2 21%)	320 minutos (~ 5.5 horas)	Habitación estándar
O2 al 100% Normobárico	1 ATA (FiO2 100% Mascarilla Reservorio)	80 minutos (~ 1.3 horas)	Servicio de Urgencias / Reanimación
Oxígeno Hiperbárico (OHB)	2.5 a 3 ATA en Cámara Hiperbárica	20 a 25 minutos	Centro de Medicina Hiperbárica especializado

TRAMPAS EUNACOM

ESCENARIO	CONDUCTA CORRECTA	ERROR FRECUENTE
Cefalea + brasero, SatO2 99%	O2 100% y co-oximetría	Alta por saturación normal
Confirmar la sospecha	Carboxihemoglobina	Gases convencionales o TAC de cerebro
COHb 12%, sin síntomas graves	O2 100% normobárico	Cámara hiperbárica

REGLA DE ORO **SatO2 normal no descarta CO** — El oxímetro marca falsamente 100%

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, preguntas **87–90** (págs. 22–23) · solucionario pág. 37.

Clase 5.4 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO

5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental

PRIORIDAD BAJA
0 preguntas reales 2013–2025

Media · RCP que parte por ventilaciones, no drenar agua, hipotermia con recalentamiento activo y manipulación cuidadosa

1.05.2.001 **Asfixia por inmersión** — Dx Específico · Tx Completo · Seg Completo

También: Hipotermia

LO QUE TE PREGUNTAN

- **El paro en el ahogamiento es hipóxico**: la RCP parte con 5 ventilaciones de rescate y luego compresiones.
- No se pierde tiempo en drenar el agua (Heimlich o posición boca abajo): no sirve y aumenta el vómito.
- **Todo ahogado se observa 6 a 8 horas**: puede desarrollar edema pulmonar o SDRA tardío.
- **Hipotermia es temperatura central menor de 35 °C**: leve 32-35, moderada 28-32, grave menor de 28 (ondas J de Osborn).
- Recalentamiento escalonado y manipulación cuidadosa por riesgo de fibrilación ventricular; la bradicardia no responde a atropina.
- **Nadie está muerto hasta que está tibio y muerto**: en paro hipotérmico la RCP se prolonga hasta recalentar.



EDEMA NO CARDIOGÉNICO, SDRA
Harrison 21.ª ed., Fig. 301-2

ALGORITMO · AHOGAMIENTO E HIPOTERMIA ACCIDENTAL

urgencia · resuelve · derivar · examen/acción

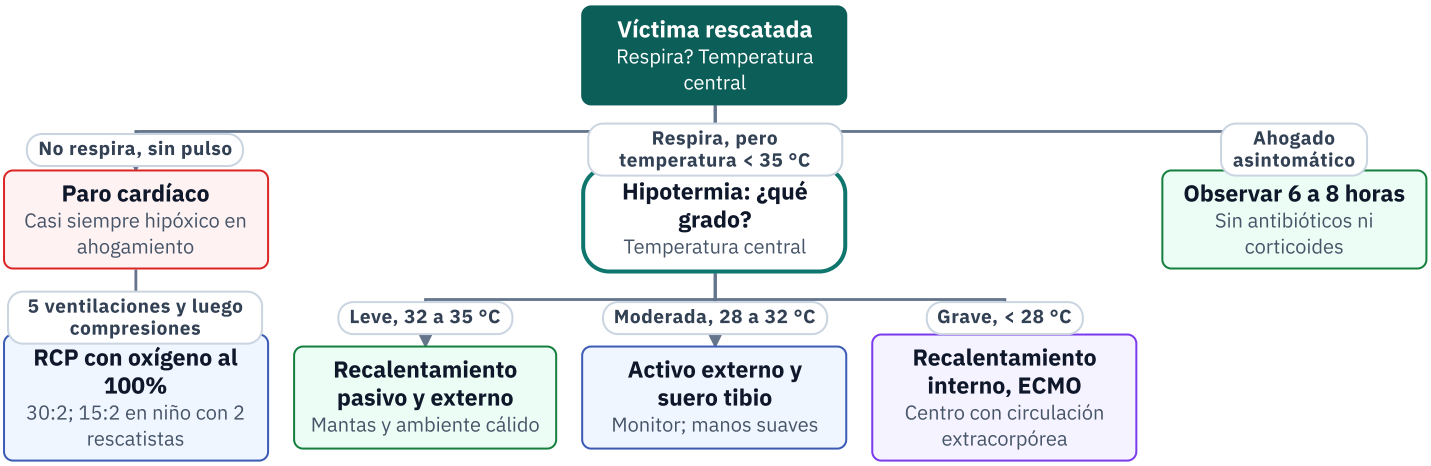


TABLA 5.5 · HIPOTERMIA: CLASIFICACIÓN POR TEMPERATURA CENTRAL Y CONDUCTA

GRADO	TEMPERATURA CENTRAL	CUADRO CLÍNICO	MANEJO
Leve	32 a 35 °C	Temblor, taquicardia, taquipnea, confusión	Recalentamiento pasivo y externo
Moderada	28 a 32 °C	Letargo, sin temblor, bradicardia, ondas J, FA	Activo externo + suero tibio · monitor
Grave	Menor de 28 °C	Coma, bradicardia extrema, FV o asistolia	Recalentamiento interno, ECMO · RCP prolongada

TRAMPAS EUNACOM · ADEMÁS DE LA TABLA

DATO	DECISIÓN	ERROR TÍPICO
Ahogado en paro	5 ventilaciones y luego compresiones	Heimlich o boca abajo para drenar agua
Ahogado asintomático, Rx y SatO2 normales	Observar 6 a 8 horas	Alta inmediata, o antibióticos y corticoides

REGLA DE ORO **Ventilar primero: 5 ventilaciones de rescate** — Luego compresiones

PRACTICA **Libro Gordo Respiratorio**, pregunta **73** (pág. 20) · solucionario pág. 34.

Clase 5.5 en video
Escanea para verla
eunacom-examen.cl

Números que tienes que saber

Cortes, dosis, tiempos y metas de los 25 temas, tal como aparecen en el libro y en las clases. Las cifras van en negrita.

DATO	TIPO
BLOQUE 01 · VÍA AÉREA OBSTRUCTIVA Y FUNCIÓN PULMONAR	
1.1 Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar	pág. 3
≥ 12% Y **≥ 200 mL** — En el VEF1 o la CVF	DOSIS
VEF1/CVF < 0,70 define — El VEF1 post-BD gradúa	CORTE
1.2 Crisis Asmática en el Adulto	pág. 4
SatO2 > **93%** · PEF > **70%** — Al aire ambiente	CORTE
Control en **≤ 7 días** hábiles — En APS o policlínico	CORTE
1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES	pág. 5
Espirometría normal no descarta — Metacolina: VEF1 cae > **20%**	META
Síntomas diurnos > **2 veces**/semana — En las últimas **4 semanas**	CORTE
Escalón 1–2: budesonida/formoterol SOS — 160/**4,5 mcg**, 1 puff a demanda	DOSIS
1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable	pág. 6
Oxígeno domiciliario > **15 h**/día — Meta SatO2 **≥ 90%**	META
GOLD 1 **≥ 80%** · GOLD 2 **50–79%** — Del predicho	CORTE
GOLD 3 **30–49%** · GOLD 4 < **30%** — Describe el pulmón	CORTE
1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)	pág. 7
Prednisona **40 mg** por **5 días** — Sin descenso	DOSIS
Paro inminente · Glasgow < 8 — Sin protección de la vía aérea	CORTE
SatO2 **88–92 %** — O PaO2 entre 55 y **65 mmHg**	CORTE
BLOQUE 02 · INFECCIONES RESPIRATORIAS BAJAS Y SUPURACIONES	
2.1 Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65	pág. 8
U: urea > **42 mg/dL** — O BUN > **19 mg/dL**	DOSIS
B: PAS < 90 o PAD **≤ 60** — Blood pressure	CORTE
GES **≥ 65 años** — Antibiótico en < **24 horas**	CORTE
2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES	pág. 9
< 65 sano: amoxicilina — **1 g** c/**8 h** · alergia: macrólido	DOSIS
Azitromicina **500 mg**/día — Por **3 a 5 días**	DOSIS
2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa	pág. 10
> 25 leucocitos, < 10 epiteliales — Si no, es saliva	CORTE
Levofloxacino **750 mg**/día — O azitromicina EV	DOSIS
2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares	pág. 11
Ampicilina/sulbactam EV — **1,5 a 3 g** cada **6 horas**	DOSIS
Luego amoxicilina/clavulánico VO — 875/**125 mg** cada **8 a 12 horas**	DOSIS
2.5 Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento	pág. 12
Una dosis al recién nacido **≥ 2.000 g** — No se revacuna	DOSIS
Pleural: **6 meses**, sin cambios — Exudado linfocítico con ADA > 40	CORTE
Influenza anual — Asma, EPOC, bronquiectasias, fibrosis, > **65 años**	CORTE
BLOQUE 03 · PATOLOGÍA PLEURAL Y URGENCIAS TORÁCICAS	
3.1 Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light	pág. 13
Rx de pie: más de **150–200 mL** — Borra el ángulo costofrénico	DOSIS
Proteínas > 0,5 · LDH > 0,6 · LDH > 2/3 — Líquido y suero al mismo tiempo	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental (cont.)	pág. 27
Los tres criterios de Light: Prot LP/S > 0.5, LDH LP/S > 0.6, y LDH LP > 2/3 del límite normal sérico.	CORTE
3.2 Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural	pág. 14
2 a 4 semanas en total — Mínimo **14 días** EV, luego oral	TIEMPO
3.3 Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario	pág. 15
Pequeño: oxígeno + observar — Menos de **2 cm** en el hilio	CORTE
Fuga aérea persistente — Burbujeo después de **48 a 72 horas**	TIEMPO
3.4 Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático	pág. 16
Hemotórax masivo — Matidez + sangre **≥ 1.500 mL**	DOSIS
Toracotomía: **1.500 mL** o **200 mL**/h — Por **2 a 4 horas**	DOSIS
3.5 Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa	pág. 17
Linfocitos > **50 %**: TBC o cáncer — El ADA decide la sospecha	CORTE
Un ADA en líquido pleural **≥ 40 U/L** tiene altísima especificidad para pleuritis tuberculosa.	CORTE
Citología del líquido — **60 %** en la 1.ª muestra; **80–85 %** con la 2.ª	CORTE
BLOQUE 04 · ONCOLOGÍA PULMONAR, INTERSTICIO Y VASCULAR	
4.1 Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner	pág. 18
Menor de **6 mm**, bordes lisos — Netos y regulares	CORTE
6–8 mm: TAC seriada — Más de **8 mm**: PET-CT o tejido	CORTE
4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial	pág. 19
Células grandes: **10 %** — Periférico, indiferenciado y agresivo	CORTE
Epidermoide: **25–30 %** — Muy ligado al tabaco, tiende a cavitar	CORTE
Adenocarcinoma: **40–50 %** — El más frecuente, también en no fumadores	CORTE
4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática	pág. 20
TACAR: NIU = FPI — Sin biopsia si es típico y > **60 años**	CORTE
Crépitos secos tipo velcro — Teleinspiratorios, bibasales, en más del **80 %**	CORTE
Población habitual · Hombres > **60-65 años**, fumadores · Mujeres jóvenes a maduras, no fumadoras	CORTE
4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación	pág. 21
FC > **100 lpm** — +1,5	CORTE
Wells **≤ 4**: dímero D — Negativo descarta	CORTE
Paro inminente: **0,6 mg/kg** en **15 min** — Bolo rápido	DOSIS
4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias	pág. 22
Leve: < **30 mL**, estrías — Mediana: 30 a **150–200 mL**	DOSIS
> **150–200 mL** en **1 hora** — O > **500–600 mL** en **24 horas**	DOSIS
Embolización bronquial — **90 %** de origen bronquial	CORTE
BLOQUE 05 · CUIDADOS CRÍTICOS, VENTILACIÓN Y MEDICINA DEL SUEÑO	
5.1 Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica)	pág. 23
PaO2 < **60 mmHg** — Con o sin PaCO2 > **45 mmHg**	CORTE
Índice ROX < 3,88 — Alto riesgo de falla del alto flujo	CORTE
5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín	pág. 24
6 mL/kg de peso ideal — Plateau **≤ 30 cmH**2O	DOSIS
PaFi < 150: prono **≥ 16 h** — Reduce la mortalidad	CORTE
5.3 Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS)	pág. 25
Severo: IAH **≥ 30** — El corte de CPAP es 15	CORTE

Números que tienes que saber · continuación

DATO	TIPO
5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental (cont.)	pág. 27
IAH **≥ 15**: CPAP nasal — O leve con somnolencia, HTA o chofer	CORTE
5.4 Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo	pág. 26
COHb > **25%** — En cualquier paciente	CORTE
O2 **100%** con reservorio, **≥ 6 h** — Vida media: 320 → **80 min**	CORTE
5.5 Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental	pág. 27
Oxígeno con meta SatO2 > **94%** — CPAP, VMNI o intubación si persiste	META
Peor pronóstico — Sumersión > **10 min**, asistolia, pH < 7,0	CORTE

Fármacos de primera línea

Esquemas de elección por enfermedad, tomados de las tarjetas de tratamiento de cada clase. Al final de la sección, las garantías GES.

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE
1.2 Crisis Asmática en el Adulto		pág. 4
La primera hora · Oxígeno y broncodilatadores	**Salbutamol 4–8 puff cada 20 min**	Durante la 1ª hora, con aerocámara
La primera hora · Oxígeno y broncodilatadores	**+ Ipratropio en moderada y grave**	4–8 puff o **500 mcg** nebulizado cada **20 min**
Receta de egreso	**Prednisona 40 mg/día por 5–7 días**	Sin esquema descendente
Receta de egreso	**SABA de rescate + corticoide inhalado**	Iniciar o escalar la mantención
1.3 Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES		pág. 5
Escalones GINA, vía preferida · Escalones 1 a 3	**Escalón 1–2: budesonida/formoterol SOS**	160/**4,5 mcg**, 1 puff a demanda
Qué hace el médico general · Deriva al broncopulmonar	**Eosinófilos, IgE; biológicos o termoplastía**	
1.4 Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable		pág. 6
Lo que cambia el curso	**Diuréticos con cuidado**	Alcalosis metabólica reduce el impulso respiratorio
1.5 Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)		pág. 7
Qué gérmenes y con qué · Primera línea en Chile	**Amoxicilina/clavulánico 875/125 mg**	Cada **12 h** por **5 a 7 días**
Qué gérmenes y con qué · Primera línea en Chile	**Azitromicina 500 mg/día 3–5 días · cefuroximo 500 mg c/12 h**	
Broncodilatador y corticoide · Broncodilatación	**Salbutamol + ipratropio**	4 a 8 puff de cada uno, con aerocámara
Tratar la exacerbación	**Diurético de asa con cautela**	Vigilar potasio y bicarbonato
2.2 Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES		pág. 9
Menor de 65, sin comorbilidades · Primera línea	**Amoxicilina 1 g c/8 h oral**	Por **5 a 7 días**
Sala general · Primera línea	**Ceftriaxona 1–2 g/día EV**	O ampicilina/sulbactam **1,5 g** c/**6 h** EV
Unidad de cuidados intensivos · Primera línea	**Ceftriaxona 2 g + levofloxacino 750 mg**	Ambos EV, al día
Unidad de cuidados intensivos · Primera línea	**O ceftriaxona + azitromicina EV**	Betalactámico + atípico
2.3 Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa		pág. 10
Intracelular	**Levofloxacino 750 mg/día**	O azitromicina EV
El que no protege su vía aérea · Cubrir anaerobios	**Ampicilina/sulbactam 1,5–3 g c/6 h EV**	O amoxicilina/clavulánico
Aparece después de 48 horas · Antipseudomónico	**Piperacilina/tazobactam 4,5 g c/6 h**	O cefepime **2 g** c/**8 h** EV
Aparece después de 48 horas · Antipseudomónico	**+ vancomicina si sospecha de SAMR**	Previa toma de cultivos
2.4 Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares		pág. 11
Médico, anaerobios y largo · Esquema de elección	**Ampicilina/sulbactam EV**	**1,5 a 3 g** cada **6 horas**
Médico, anaerobios y largo · Esquema de elección	**Luego amoxicilina/clavulánico VO**	875/**125 mg** cada **8 a 12 horas**
4.2 Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial		pág. 19
Manejo inicial	**Dexametasona + protección gástrica**	Para el edema
4.3 Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática		pág. 20
Toxicidad intersticial	**Amiodarona**	La causa más frecuente en cardiología

Fármacos de primera línea · continuación

SITUACIÓN	FÁRMACO / ESQUEMA	DETALLE	
5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín (cont.)			pág. 24
Toxicidad intersticial	**Metotrexato, bleomicina, nitrofurantoína**	Esta última en uso crónico	
4.4 Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación			pág. 21
Anticoagular · Primera línea	**Rivaroxabán**	**15 mg** c/**12 h** por **21 días**, luego **20 mg**/día	
Anticoagular · Primera línea	**Apixabán**	**10 mg** c/**12 h** por **7 días**, luego **5 mg** c/**12 h**	
Anticoagular · Alternativa parenteral	**Enoxaparina 1 mg/kg c/12 h SC**	De elección en cáncer activo o embarazo	
Anticoagular · Alternativa parenteral	**Traslape a acenocumarol o warfarina**	Meta INR 2–3	
4.5 Hemoptisis y Bronquiectasias			pág. 22
Clínica, diagnóstico y manejo · Crónico	**Antibióticos en las exacerbaciones**		
Clínica, diagnóstico y manejo · Crónico	**Vacunas**	Antiinfluenza y antineumocócica	
5.2 Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín			pág. 24
Derivar a UCI	**Dexametasona 6 mg por 10 días**	Si requiere oxígeno; anticoagulación profiláctica	

GES de Respiratorio

Garantías Explícitas en Salud que aparecen en los temas de esta especialidad: el EUNACOM pregunta la edad, el examen y el plazo que garantizan.

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Diagnóstico y Confirmación de Asma y EPOC en APS**

Tema **1.1** · Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar
`1.05.4.005` · `1.05.4.012`
pág. **3**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de Urgencia del Asma Bronquial Moderada o Grave**

Tema **1.2** · Crisis Asmática en el Adulto
`1.05.2.004` · `1.05.4.009` · `1.05.4.010`
pág. **4**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Asma Bronquial en Personas de 15 años y más**

Tema **1.3** · Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES
`1.05.1.003` · `1.05.1.002` · `1.05.4.005`
pág. **5**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica en Personas de 15 años y más**

Tema **1.4** · Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable
`1.05.1.017` · `1.05.1.016` · `1.05.4.005`
pág. **6**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Manejo de la Exacerbación Aguda del EPOC**

Tema **1.5** · Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen)
`1.05.2.006` · `1.05.5.012` · `1.05.4.010`
pág. **7**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía Adquirida en la Comunidad de Manejo Ambulatorio en Personas de 65 años y más**

Tema **2.1** · Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65
`1.05.1.027` · `1.05.4.001` · `1.05.1.005`
pág. **8**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Neumonía en el Adulto de 65 años y más (Tratamiento en menos de 24 horas)**

Tema **2.2** · Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES
`1.05.1.028`
pág. **9**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Tuberculosis en Todas sus Formas (Garantía de Acceso, Diagnóstico y Tratamiento)**

Tema **2.5** · Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento
`1.05.1.036` · `1.05.3.003` · `1.05.4.004`
pág. **12**

Fármacos de primera línea · continuación

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Politraumatizado Grave (Manejo Inmediato de Lesiones Torácicas con Riesgo Vital)**

Tema **3.4** · Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático
`1.05.2.011` · `1.05.2.013` · `1.05.5.004`
pág. **16**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Pulmón y Tuberculosis**

Tema **3.5** · Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa
`1.05.1.013` · `1.05.1.010` · `1.05.5.002`
pág. **17**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Sospecha de Cáncer Pulmonar**

Tema **4.1** · Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner
`1.05.1.038` · `4.01.1.038` · `1.05.4.002`
pág. **18**

GES **Garantía Explícita en Salud (GES): Cáncer de Pulmón en Personas de 15 años y más**

Tema **4.2** · Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial
`1.05.1.007` · `4.01.1.039` · `1.05.1.034`
pág. **19**

Sin garantía GES específica (13 temas): 2.3 · 2.4 · 3.1 · 3.2 · 3.3 · 4.3 · 4.4 · 4.5 · 5.1 · 5.2 · 5.3 · 5.4 · 5.5. Revisa igual la norma MINSAL que cita cada página.

Plan de repaso de 7 días

Los temas van de mayor a menor prioridad (★ según preguntas reales EUNACOM 2013–2025). Cada día: lee la página del tema, recorre su algoritmo y haz sus preguntas del Libro Gordo; corrige con el solucionario.

DÍA 1

5 temas · ★★★

- ★★★ **2.5** Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento 12
- ★★★ **4.2** Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial 19
- ★★★ **4.4** Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación 21
- ★★★ **2.1** Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 8
- ★★★ **1.3** Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES 5

Practica: Libro Gordo Respiratorio, preguntas 11–14, 19–24, 35–36, 55, 58–62, 67–69.

DÍA 2

4 temas · ★★★

- ★★★ **4.3** Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática 20
- ★★★ **1.5** Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) 7
- ★★★ **1.4** Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable 6
- ★★★ **4.5** Hemoptisis y Bronquiectasias 22

Practica: Libro Gordo Respiratorio, preguntas 15–18, 63–66, 70–72.

DÍA 3

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.1** Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light 13
- ★★☆ **3.5** Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa 17
- ★★☆ **4.1** Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner 18
- ★★☆ **5.3** Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) 25

Practica: Libro Gordo Respiratorio, preguntas 38–40, 54, 56–57, 84–86.

DÍA 4

4 temas · ★★

- ★★☆ **1.1** Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar 3
- ★★☆ **5.1** Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) 23
- ★★☆ **5.4** Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo 26
- ★★☆ **3.2** Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural 14

Practica: Libro Gordo Respiratorio, preguntas 3–7, 41–46, 75–81, 87–90.

DÍA 5

4 temas · ★★

- ★★☆ **3.3** Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario 15
- ★☆☆ **2.4** Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares 11
- ★☆☆ **1.2** Crisis Asmática en el Adulto 4
- ★☆☆ **2.2** Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES 9

Practica: Libro Gordo Respiratorio, preguntas 8–10, 25–26, 31–34, 47–49.

DÍA 6

4 temas · ★

- ★☆☆ **2.3** Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa 10
- ★☆☆ **3.4** Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático 16
- ★☆☆ **5.2** Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín 24
- ★☆☆ **5.5** Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental 27

Practica: Libro Gordo Respiratorio, preguntas 27–30, 37, 50–53, 73, 82–83.

DÍA 7

- Relee «**Números que tienes que saber**» y «**Fármacos de primera línea**» pág. 28
- Repasa solo las **Trampas EUNACOM** y la **Regla de oro** de los temas ★★★: 1.3 · 1.4 · 1.5 · 2.1 · 2.5 · 4.2 · 4.3 · 4.4 · 4.5
- Simulacro: las **90 preguntas** del Libro Gordo Respiratorio en 120 minutos; vuelve a la página de cada tema que falles.

Índice por prioridad ★

El número a la izquierda es la cantidad de preguntas reales (EUNACOM 2013–2025) en los códigos Perfil V3 del tema.

★★★ Prioridad alta · 9 temas

17 2.5. Tuberculosis Pulmonar: Diagnóstico, Programa MINSAL y Tratamiento GES 12
15 4.2. Cáncer Pulmonar: Tipos Histológicos, Clínica y Manejo Inicial GES 19
15 4.4. Tromboembolismo Pulmonar (TEP) Agudo: Wells, Ginebra y Estratificación 21
14 2.1. Neumonía Adquirida en la Comunidad (NAC): Diagnóstico y Severidad CURB-65 GES 8
13 1.3. Asma Bronquial Crónica y Manejo GINA/GES GES 5
9 4.3. Enfermedades Pulmonares Intersticiales Difusas (EPID) y Fibrosis Pulmonar Idiopática 20
8 1.5. Exacerbación Aguda de EPOC (Anthonisen) GES 7
7 1.4. Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) Estable GES 6
7 4.5. Hemoptisis y Bronquiectasias 22

★★ Prioridad media · 9 temas

6 3.1. Derrame Pleural: Diagnóstico Diferencial y Criterios de Light 13
6 3.5. Derrame Pleural Neoplásico y Pleuritis Tuberculosa GES 17
5 4.1. Nódulo Pulmonar Solitario (NPS): Evaluación y Algoritmo Fleischner GES 18
5 5.3. Síndrome de Apnea-Hipoapnea Obstructiva del Sueño (SAHOS) 25
4 1.1. Espirometría y Pruebas de Función Pulmonar GES 3
4 5.1. Insuficiencia Respiratoria Aguda: Tipo 1 (Hipoxémica) vs Tipo 2 (Hipercápnica) 23
4 5.4. Intoxicación por Monóxido de Carbono e Inhalación de Humo 26
3 3.2. Derrame Paraneumónico y Empiema Pleural 14
3 3.3. Neumotórax Espontáneo Primario y Secundario 15

★ Prioridad baja · 7 temas

2 2.4. Absceso Pulmonar y Supuraciones Pleuropulmonares 11
1 1.2. Crisis Asmática en el Adulto GES 4
1 2.2. Tratamiento Antimicrobiano de la NAC y Criterios GES GES 9
1 2.3. Neumonías Atípicas, Intrahospitalarias y Neumonía Aspirativa 10
0 3.4. Neumotórax a Tensión y Hemotórax Traumático GES 16
0 5.2. Síndrome de Distrés Respiratorio Agudo (SDRA): Criterios de Berlín 24
0 5.5. Ahogamiento (Asfixia por Inmersión) e Hipotermia Accidental 27